

糖尿病的预防

【编译：薛佩臻/TrustMed 医学编译中心】

对于高危人群而言，糖尿病预防的重要性因这几年来全球糖尿病的日渐盛行而益发凸显；遗传的感受性，在特定族群中发生第二型糖尿病扮演重要的角色。然而，假使族群基因库变动得十分缓慢，当前流行病可能反映出生活形态上显著的改变。

以减少身体活动、增加能量摄取为特征的生活形态改变，造成了肥胖，后者是糖尿病的烈危险因子，而糖尿病同时受到基因和行为影响。尽管维持长期的减重十分困难，几项研究却证实，持久的适度减重可以巨幅降低罹患第二型糖尿病的风险。

来自美国和芬兰的临床试验数据目前已经强烈支持适度减轻体重可以降低糖尿病风险的可能性。在许多前瞻性研究中，活跃的生活形态已被证实可以预防或延缓第二型糖尿病的产生。中度和剧烈的运动皆能降低葡萄糖耐受性不良和第二型糖尿病的风险。减少总体脂肪的摄取，尤其是饱和脂肪，可以降低糖尿病的风险。

据报导指出，独立于总卡路里之外，随着饮食脂肪的增加，糖尿病的发生率也上升，虽然这个影响还未获得所有研究的证实，但显然所有类型的饮食脂肪（n-3 脂肪酸除外）可能对胰岛素的敏感性有不利的作用，而饱和脂肪可能造成的影响最大。在维持良好体重管理所需摄取的适当总能量要求下，增加多元不饱和脂肪的摄取，可以减少罹患第二型糖尿病的风险。

最近的研究证实，增加全谷和膳食纤维的摄取，可以降低罹患糖尿病的风险。虽然经过挑选出来的微量营养素可以影响葡萄糖和胰岛素的新陈代谢，但能用来证明引发糖尿病的数据，不是很缺乏就是互相矛盾。适度的酒精摄取和促进胰岛素敏感性、减低糖尿病风险息息相关。然而，对摄取适度酒精以预防第二型糖尿病的特殊建议仍缺乏充分数据。

并没有营养建议可用来预防第一型糖尿病，不过喂母乳可能是有益的。虽然年轻人肥胖率的增加（特别是少数种族的青少年）可能和第二型糖尿病的日益盛行有关，但目前保证可以预防年轻人第二型糖尿病的任何特殊建议，都没有充分的数据。增加身体活动、减少能量和脂肪摄取，以及控制体重可能会证明是有益的。

【营养建议】

A 级证据

※强调改变生活形态的有组织方案，包括加强教育、减少脂肪和能量摄取、规律的身体活动，以及定期与参与者联系，可以产生减轻原来体重 5-7% 的长期效益，而降低罹患糖尿病的风险。

B 级证据

※所有人，尤其家族有人罹患第二型糖尿病者，必须鼓励他们从事定期的身体活动，以减少罹患第二型糖尿病的风险。【审阅】郑维理医师，TrustMed 医学编译中心【导读说明：本系列共二十六篇】本文是由美国糖尿病协会(American Diabetes Association)发表的评论。

英文标题为：Evidence-

Based Nutrition Principles and Recommendations for the Treatment and Prevention of Diabetes and Related Complication.（有事实根据的营养原则与建议：糖尿病和相关并发症的治疗与预防）

评论

此篇论文足足有 26 篇之长,有如老太婆的缠脚布是又臭又长,说了半天完全无助于事,到目前为止仍然有一大堆人得到糖尿病,也没有一个西医治好的案例,一大堆人终身受到胰岛素的控制,死的时候是因为肾脏衰竭或截肢手术造成的(如前台湾总统蒋经国先生),所有相信西医的人已经把西医当成宗教般的信仰,完全失去自己的意识及智慧,盲目的去信仰已经变成迷信西医,大众并不了解西方医学,却无知的去相信,这才是真正的死在自己的迷信上。

有关于糖尿病的防治非常简单,以下几点建议可供参考:

- 1.不要吃消夜,以免造成睡觉时过多食物在肠胃中无法消化,促使体内糖份增加.
- 2.食不过饱,大约七分饱,不感觉饿就可以了.
- 3.不要吃油炸食物太多,造成消化系统的过量负担.
- 4.禁止使用抗生素,得到感冒时服用中药,(我有许多病人因为肺炎经过服用 Cipro 此强力抗生素后血糖升高),许多糖尿病患者,都是因为吃到抗生素过多,破坏胰脏而使血糖升高,原来根本没有此病.
- 5.适合的运动,如打太极拳,走路,游泳等.
- 6.一旦得到糖尿病须要找中医治,血糖高不会造成青光眼,只要顾好肾脏,加强心脏的功能,在按照以上的方法就会好的.

惊慌及乱用西药,是造成人们死于糖尿病的主要原因.请告诉你们的亲友此建议,不要告诉你们的敌人,让西医用合法的手段来杀死你的敌人,不是很好吗?(详见 HT-24)

糖尿病足中药有潜力

陈恒民 / 林口长庚医院中医内科主治医师

糖尿病患者,最怕身上出现伤口。一来是因为伤口容易感染;二来是伤口一旦出现,往往迁延日久,难以愈合。所以,一般医师都会嘱咐病患要穿袜子,最好再穿上合适的鞋子,并且时常检视自己的双脚,察看是否有伤口的出现。

因为伤口最常发生在足部,因而有了「糖尿病足」这个名词。此病的发生,并不一定具有明显的外伤病史,很多的病人,不知不觉的,脚上就出现了伤口,令人相当困扰。

目前西医在治疗上,采取口服抗血小板凝集药物,如阿斯匹林,并辅以外部清疮换药治疗,再视感染的有无,以决定是否加入抗生素。对于快速蔓延无法控制的伤口,须以截肢的方式处理。伤口的形成,与周边神经病变及血管病变最为相关。而周边神经病变的发生,除了高血糖所诱发的代谢异常,就以缺血所致神经细胞失养性病变为主。由此可知,血管病变所导致组织缺血,实为此病之主要因素。

糖尿病所引发之血管病变,可以区分为两大类:第一类为大血管病变,这一类即为大家所熟知之血管动脉硬化;第二类为小血管病变,它是因血管内皮细胞功能缺失,使血管无法正常扩张以供应组织之需求所致。针对前者,我们可以外科手术方式,采血管绕道手术,将血液送到缺血的组织。但对于后者,则尚无有效的治疗方式。再说,临床上这两种血管病变,几乎是一并发生。所以我们常可以看到有些病人,即使接受了血管绕道手术的治疗,糖尿病足依然发生。

传统中医虽然没这些微观的观察记载,但是透过对症状的治疗,累积了相当有价值的治疗经验。根据糖尿病足发病的机理,它属于中医学里血瘀的范畴。治疗上,以活血化瘀为其主要方式。在目前的中药研究中,可以发现,中药是透过各种不同层面,来治疗血瘀症问题。

其中某些药物具有类似 coumadin 或阿斯匹林的抗凝作用。这其中包括大家所熟悉的当归、丹参、川七等。另外有一些药物,如山梔子,甚至可以使失能的血管内皮细胞恢复功能,此现象着实令人振奋。

另外在一些复方的临床实验报告中,对于周边血液灌流的改善,及糖尿病足伤口的愈合,乃至感染的预防,皆有显著的效果。这些初步的成果,让我们深深觉得,中药对于糖尿病足的治疗,似乎潜力雄厚。不过笔者必须特别强调,无论以何种方式治疗,良好的血糖控制,仍是最基本的步骤,尤其针对小血管病变,此点更为重要。只有血糖控制得当,其它的治疗才能发挥效果。病患千万不要贸然停掉原本使用之降血糖药物,一旦如此,未蒙其利,先受其害,不可不慎。

评论

中药对于任何的伤口恢复,皆有很好的效果,不单是「糖尿病足」至于上篇论及不要停止使用

降血糖药,这是一个大问题,就是因为病患使用降血糖的西药而造成大量的血糖累积在双脚上,因此而破坏血管以及血液的循环,才会有伤口不易愈合的现象,君不见西医每次要病患取手上一滴血,来查血糖多高,从未有西医要病人取脚指上一滴血,来查血糖的,就是因为降血糖药只能降上半身的血糖,无法降下半身的血糖.

举例来说明,比如有一人,其验血得知血糖为 300,经服用降血糖药后,血糖降低到 100,表面上看起来很好,实际上少掉的 200 仍然在身体里,"按照物质不灭定律"去掉的血糖会停留在下身,结果脚指取得的一滴血中血糖是 500,如与手指上的加起来就是 600,除以 2 就是 300,也就是说血糖根本没有变

由于过多的血糖停留在脚中,日子久了以后,就形成「糖尿病足」,西医不承认是西药制造出来的问题,诸君只要稍微细想一下,为什么只有糖尿病有此现象呢?每见病人开始使用降血糖药物之后一段时间之后就发生了,许多糖尿病患者采用节食法自行控制血糖,就完全没有此问题呢?前总统经国先生就是因此而死亡,他就是迷信西医而造成此一结果的.

随餐注射胰岛素糖尿病患用药方便不昏倒

(中央社记者陈清芳台北七日电)许多糖尿病患一提到注射胰岛素,心头蒙上「完了,我的病没救了」的阴影,或以为「打胰岛素会愈打愈重,打了还会昏倒」,事实不然,选择生效快、药效短的胰岛素,随餐注射,使用方便不易忘记,有助于控制病情。

糖尿病基金会董事长戴东原今天指出,依据这几年来在台湾各层次调查结果显示,绝大多数糖尿病患者都使用口服降血糖药物,接受胰岛素注射的仅约百分之十二,低欧美国家的百分之三十左右。

戴东原指出,这不是台湾的糖尿病人病情控制得很好,而是糖尿病人对注射胰岛素的误解,不过,传统的胰岛素注射剂确实有些缺点,戴东原举例:必须用餐前三十到四十五分钟注射、注射六到八小时后容易发生低血糖昏迷。

他说,再加上病患注射时胰岛素的疼痛、担心自己病情曝光等心理压力,使得病人认为注射胰岛素很不方便,经常忘记或疏忽用药,一旦病情控制不佳,便怪罪注射胰岛素让病情更加严重。

由于人体在进食十五分钟后,血糖上升,需要胰岛素吸收营养素,戴东原说,新一代的胰岛素可随餐使用,药效生效时间模拟人体胰岛素释放的模式,再加上药效仅三到四小时,正好是两餐之间的间隔,就不容易因为胰岛素作用时间太长,导致血糖太低而昏倒。

戴东原强调,许多研究与证据均显示当糖尿病的病情进展到晚期时,注射胰岛素是最直接有效的治疗方式,可减少糖尿病晚期的视网膜病变、糖尿病脚部病变、肾衰竭等许多严重并发症。

评论

这位祸国殃民的糖尿病基金会董事长戴东原先生应该去自杀了,这篇祸害千年的报导也拿出来丢人现眼,我不知已经治疗过多少糖尿病患者,有的已经面临截肢的阶段才来找我,我都将之治疗好转了,这些视网膜病变、糖尿病脚部病变、肾衰竭等许多严重并发症,根本就是因为使用西药的口服降血糖药或是注射胰岛素造成此类后遗症的,糖尿病根本不会造成此类问题的,糖尿病患者就是因为一直服用西药的口服降血糖药,以及注射胰岛素造成手指上的血糖下降,脚上却有过多的沉淀糖累积在脚上才造成脚部病变,口服降血糖药以及人工合成注射胰岛素不但糖根本没有清出体外,累积在脚上,更会造成肝肾脏损伤,因此才产生青光眼等视网膜病变与肾衰竭等问题,(详细请看 HT-24),这位混蛋不单是中华文化的背叛者,简直会害死我们后代子孙,我不得不狠狠骂一下,才能稍微平息]我的愤怒,此人我猜一定是西医或西药的进口商之类的人.

我可以很明确的告诉读者以下四重点:

1.每位在服用糖尿病的口服控制片剂或注射胰岛素的病患,使用越多年你的脚就越痛之后就

越麻,脚的病变因此而来.

2.不使用西药的聪明人,利用食物或中药来治糖尿病的人,一生也没有脚的问题.

3.高血糖的确会伤到肾脏,但是保护肾脏对优秀中医来说是非常简单的,正确使用中药糖尿病是可以治疗好转的.

4.台湾前总统蒋经国先生是西医的迷信者,此人从不吃中药的,而他贵为总统可想而知其有专属的医疗团队,这些医护人员忠心保

护总统健康是值得嘉奖的,但是他们手中拿给总统的糖尿病的口服控制片剂或胰岛素注射针器,才是真正致命的原因,他死前经历

了截肢手术,就是胰岛素造成的脚糜烂.老总统极相信中医,所以才有郑曼青先生,他活的比他儿子长许多就是因为相信中医,所

以前总统蒋经国先生是笨死的,这是最标准案例,我们要从这例子学习到不在犯同样的错才是智慧.

西谚有云:聪明的人从愚笨人身上学到的东西,远比愚笨的人从聪明的人身上学到的要多许多.

我每次骂人骂的很凶,诸位一定很纳闷为什么?我告诉诸位易经的卦中有一卦叫[山水蒙]其言道:启蒙之道,必也刚中,再筮不

中与也.就是说要启人之蒙必须要一言就中,而且要很刚硬,如果对方一再重复问同一问题就是不中了,也就改变不了了,为了救

这些蠢蛋,余不得已也,非余所愿也.

胰岛素自动注射帮浦省去糖尿病患者打针麻烦

【记者陈清芳台北十三日电】对于要注射胰岛素的糖尿病患者来说,可以不必打针了,患者可在肚子或手臂的皮下植入及软管,连接到自动帮浦上即可注射胰岛素,一位专治糖尿病的医师本身也患了糖尿病,他使用这个装置,成为最好的示范病人。

林口长庚医院新陈代谢科主治医师林佳鸿罹患第一型糖尿病患者,他平日把胰岛素帮浦放在上衣口袋里,帮浦储药桶连接的软管针头即可自动注射胰岛素到体内,连续控制血糖,如果他不说话,诊间的糖尿病患者都不知道,还以为他只是把呼叫器放在上衣口袋里。

他指出,胰岛素帮浦和一般传统注射法最大不同之处在于,胰岛素不再藉由空针一次大量的注射至皮下,而是经由帮浦及皮下软管,将胰岛素持续地输注入体内,浓度稳定,提供他一天所需的胰岛素。

胰岛素帮浦于一九八〇年间问世,经过改良在九十年代后开始普及,此后使用者即快速增加,现今全世界已有接近三十万糖尿病患者选择此种治疗来给予胰岛素,目前在美国也有超过六成罹患糖尿病的医护人员,选择帮浦来控制血糖。

这种自动帮浦目前尚未列入健保给付,一套的自费是新台币十八万元,它以二种输注方式来控制病患的血糖,一种是二十四小时持续而少量地注射基础胰岛素,另一种是用餐前或高血糖时所给予的追加量,使用者只需将针打入皮下组织,再将硬针头抽出留下软针在皮下组织,胰岛素由软针注入至体内,每三天换一次针管组。

评论

糖尿病是可以治疗的一种疾病,现在我的临床经验可以很确定告诉大家是第二型的糖尿病,也就是西医所谓非依赖型胰岛素的糖尿病患者,至于第一型属于依赖胰岛素型的糖尿病患者,我就无法肯定了,因为每次有这类患者来看我,我要他们停止使用胰岛素时,他们就已经吓坏了,结果都不了了之,没有继续来做治疗,所以我无法确定,一般我会说如果是初诊时尚未经西医确定是第一或第二型的糖尿病时,是最好治的阶段,如果经过西医洗脑之后就很难治了,因为病人已经被西医吓死了,我们中医还未开始治疗就已经因为病患慌乱害怕,先输着了。

这篇报导的错误在这位有糖尿病的西医师是专门治糖尿病的医师这句话,应该说这是位专门研究如何控制血糖的医师才正确,因为他又没有治好任何糖尿病患者,如何能说是专治糖尿病

的医师呢?那我这位非专门治糖尿病的小中医却治疗过许多糖尿病患者,记者又该如何称呼我呢?

醣禄类降血糖药可预防糖尿病

【王薇涂棠銓】国内的糖尿病患者越来越年轻化,临床上甚至出现有家族遗传病史的小朋友,10岁就发病,不过国外的临床实验证明,糖尿病高危险族群服用「醣禄类」的降血糖药物,可以延缓糖尿病的发病时间长达5年,还能降低九成的心肌梗塞风险。

国内的糖尿病人口高达40万人,其中50岁以下的年轻病患就有25万人!而且发病年龄越来越年轻化,临床上甚至出现10岁的小小糖尿病患。

有家族遗传病史的糖尿病高危险族群,现在可以透过药物预防发病。根据加拿大的跨国临床实验证明,服用醣禄类的降血糖药物可以延缓罹患糖尿病的时间长达5年,而且还能预防心血管疾病。

这种降血糖药物可以抑制淀粉吸收,还有减肥效果!如果是预防性的治疗,健保不给付,每天的药费大约30块钱,不过医师呼吁有家族病史的民众,控制饮食、规律运动,是预防糖尿病的根本方法。

评论

诸位看这篇的结尾,是(不过医师呼吁有家族病史的民众,控制饮食、规律运动,是预防糖尿病的根本方法。),民众们有看到吗?答案是没有,因为无知的人居多数,一般人看书的习惯只有专注前段,书尾很少去看,所以一开始就被前段迷惑了,真正要预防糖尿病的方法除了上篇结尾所述的之外,吃消夜是得到糖尿病的主因,诸君看看台湾到处有夜市,多姿多彩的夜生活就是其因,早睡早起运动的人,何来糖尿病呢,不要吃西药与维他命等烂药,也会减少得到糖尿病的机率的。

美医学会:脱袜子健康检查可及早发现糖尿病【中央社】

(中央社记者张蕙燕达拉斯十五日专电)糖尿病早期征兆可以从脚中透露端倪!美国足科医学协会呼吁大众,在作健康检查时,千万记得要把袜子脱下来,让医生好好地检查一番。(西医已经道穷了,所以分科越分越细,居然跑出个足科来,真正可以治病的医师只要一科就够的就是完整人科。)

美国足科医学协会表示,从脚部的健康情形,可以诊断人们是否已经处于早期糖尿病,而且愈是及早发现,愈可以避免糖尿病导致截肢的悲剧发生。(西医一贯手法就是在说之前先要吓死人,于是笨蛋就会言听计从了)

协会说,每年进行足部健康检查,可以降低百分之八十五的糖尿病截肢情形。足部透露出早期糖尿病征兆的现象,包括:足部红肿、麻木、血液循环不良导致脚部冰冷、和脚部外观明显产生变化。(这在乱说一通,如果你出现这些足部症状除非你扭伤了,否则是早期心脏有问题了,跟糖尿病无关)

协会指出,全美国估计有五百二十万的糖尿病患者并不清楚自己已罹患糖尿病,更不了解糖尿病的早期征兆,结果在没有及时治疗的情况下,导致心脏病、中风、高血压、失明和肾脏病等,甚至还要截肢。(这段就是会杀人的谬论,只有被西医判定得到糖尿病的病人,然后听西医的话使用西药降低血糖,而这被下降的血糖就屯积在病患双脚里,根本没有消失,经年累月的屯积糖就造成双脚红肿疼痛,一旦有伤口就不会愈合,结果就是截肢,所以这是吃西药的副作用,根本与糖尿病无关,西医却把这西药的后遗症说成是糖尿病的问题,真会狡辩,至于所谓的导致心脏病、中风、高血压、失明和肾脏病等也是不正确,脾主甘味,脾气盛故甘味盛,甘伤肾,肾伤才伤心,所以中医治糖尿病必先顾肾,肾强则心无虑,中风就是心伤,西药都伤肝,肝主目,故肝伤则目伤,所以是吃降血糖药才会失明,也就是说不用西药控制血糖还没事,西药越用多,其副作用就是导致心脏病、中风、高血压、失明和肾脏病截肢等。)

据统计,美国共有超过一千三百万的糖尿病患者,其中百分之六十至七十都同时有严重的

足部神经受损与疼痛现象。(这里说明了美国西医无法治糖尿病,都在使用药物来控制血糖才会如此,所以才有今天这数字出现,对不?)

评论

喂!做人真可怜,因为好端端的没有事,还要被这些烂西医吓一下,这篇报导适足以说明这些美国足科西医有多差,我常说做

一位医师永远不要发表一些半生不熟的医学理论,会暴露自己的无知还不自知,西药厂从不去强调西药的副作用,因为如果说清

楚讲明白的话,谁会要这副作用比原本的病更可怕的药物呢?

糖尿病本身非常好治的,找北派经方家就很快可以治好的,上文红字是由北派经方家成立的私设中医卫生署说的,大家鉴赏之.

结论是:我从一个在我妈心中的好宝宝,现在变成烂医师心里的坏宝宝,就是被这些烂西医搞出来的就是被他们害的,谁愿意呢?

附注说明:我说可以治好的糖尿病是现在西医所谓的第二型糖尿病,第一型糖尿病也就是西医定义下的胰岛素依赖型,我不能肯

定是否可以完全治好,原因是我每次遇到这类病患时,都因为他们害怕停止使用西药,造成半途而废了,至为可惜,所以至今仍无

完整案例可循.

控制糖尿病 10 大保命诀【联合新闻网记者薛桂文 / 英国伦敦报导】

全球估计有 1 亿 9000 万人罹患糖尿病,其中三分之二的血糖控制未达理想目标,导致心血管、视网膜、肾脏病等并发症层出不穷,庞大的医疗支出与社会成本,已成许多国家严重的公共卫生课题;专家疾呼,目前保守、渐进的糖尿病管理方式,亟须改采更积极、密集的策略,以减少它对人类的威胁。(会有这么多人得到糖尿病都跟西药有关,第一型糖尿病是注射疫苗所造成的后遗症,第二型的糖尿病也可以说是西医制造出来的,这段说血糖不控制好会导致的问题,其实都是因为病人吃西药控制血糖,产生的西药副作用,不使用西药根本没有这些问题存在的.)

由九国、18 位专家所组成的「全球糖尿病有效管理同盟」,经过一年审慎讨论,订出了十项有助更佳血糖控制的实用步骤,即将发表在 11 月号的「国际临床实务期刊」,而在正式出刊前,同盟特于伦敦举行媒体高峰会,公布其详细内容(见表一)。(这是由一群从未治好过糖尿病的医师所组成的同盟,所以他们只是代表不能够医治糖尿病的医师,不能代表中医的.)

同盟成员、意大利比萨大学医学教授 Stefano DelPrato 表示,医界目前已有许多糖尿病治疗准则,但往往内容互异、不够明确,甚至态度过于保守,缺乏与病患的沟通,且对其病理成因不够重视,致不当处方;所以,同盟订出的十步骤,并非新的治疗准则,而是有助疾病控制的实际建议。(此人在胡说八道,西医根本没有治疗准则,只有控制准则,读者不信,去问问你的西医师,看他怎么说.)

综观这十步骤,积极、及早介入是其核心原则。例如,监测「糖化血色素」已被医界认同为血糖控制的最佳指标,但各国的理想标准宽严不一,像美国糖尿病学会、加拿大、澳洲及台湾都以低于 7% 为标准,但愈来愈多团体建议提高标准,如国际糖尿病学会、美国临床内分泌学会的标准都是 6.5%,同盟也以此为标准。(这里又说明是如何控制准则,上段却说是治疗准则,他们自己都搞不清楚自己在做什么,我来给他们从新命名吧,他们这组织又名:无法医治糖尿病医师同盟会.所以真正能够医治糖尿病的医师是不准加入的.因此里面没有中医师.)

美国骨病家庭医师委员会大使 James LaSalle 指出,研究已证实,糖化血色素每低 1%,糖尿病的相关死亡率就减少两成,微血管并发症(如肾脏、视网膜)少 37%,心血管并发症

也可降低 14%，且正常人的标准在 5%到 6%间，订 6.5%已经嫌高，何况是 7%。(会造成糖化血色素过高,就是因为滥用抗生素造成的,此人却不说出来,只是断章取义的跳着说话.这就是西医的一贯手法.)

他认为，保守的想法认为，把标准订得高，患者达不到易挫折、放弃，所以就妥协降低标准；但医疗应以病人的最佳利益来考虑，标准高，医界应设法协助患者达到，怎可与病人一起退缩？(这种标准就是西药厂创造利润的地方它们将标准定的越高,药就卖的越多,这种标准不但完全无益于病人,反应害死病人,读者记住,对西药厂有利时就是对病人有害,而他们的身后都隐藏着西药厂.)

此外，同盟建议，每三个月至少测一次糖化血色素，作为调整治疗的依据，而且应在六个月内达到理想目标（低于 6.5%），因为，高血糖拖得愈久，控制愈难，所以一旦三个月的治疗还未达理想，就应考虑综合药物治疗。(糖尿病被西药控制越久,中医就越难治疗它,吃西药越多,中药就越须要加重,西药控制的病人到后期时,也都完全无法再控制,于是就出现人人都是蒋经国先生第二.)

加拿大多伦多大学医学教授 BernardZinman 表示，传统糖尿病医疗采「渐进式」，先由饮食、运动控制开始，效果不彰才使用单一药物，疗效欠佳一段时间后，再加入其它药；据研究，糖尿病人从单剂治疗改为综合药物治疗，平均需时 14 到 21 个月，而这是否有益疾病控制，已遭到愈来愈多质疑。(因为西药厂根本没有真正在治疗,都只是控制,所以连使用西药的西医都开始怀疑了.)

事实上，及早、密集的综合药物治疗，已证实有助糖尿病患达到目标血糖值（成效约为单剂疗法的两倍），且其眼睛病变可因此减少 21%、早期肾伤害减少 33%；尤其，对初诊断时糖化血色素就过高者（9%以上），不仅综合疗法要及早介入，必要时更应立即注射胰岛素，而非等到药物无效才用这最后法宝。(这最后法宝却是致病人于慢性死亡的法宝,真是害人!)

专家强调，要达到上述原则，并非医师在门诊时卫教，或是发给手册文宣就足够；「人都是好吃懒做的，」伦敦 Hillingdon 医院糖尿病中心顾问医师 RowanHilson 一语道破，人人都知道糖尿病控制最重要的是饮食和运动、再辅以药物，但人性的弱点却让患者很难遵照医嘱，达到理想目标。(全篇只有这里是对的,我们一定要运动,因为我们是人,是动物的一种.)要克服人性弱点，不能单靠病人或医师，而需由病人与专科医师、家庭医师、护理人员、营养师等共组跨科际的照护团队，充分沟通，以病人为中心，了解其想法、需求和困难，一起找出最适当的治疗方式，让控制糖尿病成为患者与医疗团队的责任，唯有如此，人类与糖尿病的战役，才有吹起胜利号角的一天。(这里终于承认西药只是在控制,如果只能控制时,不可能吹起胜利的号角,这一天不会到来的,只有中医能够战胜糖尿病的.)

最佳血糖控制十项步骤 VS 虚拟中医卫生署治疗糖尿病的十项步骤

良好血糖控制目标定义为糖化血色素（HbA1c）小于 6.5%。1.不要去控制血糖,一旦西医说你血糖过高,就找中医看.

除了例行血糖自我监测，三个月应测量一次糖化血色素。2.不须要检查,自己吓自己而已,西医要吓倒你,才有办法控制你.

高血糖、血脂异常、高血压等，都应以同样积极、密集的 3.病人必须积极的由中医治疗,请记住我们公布的六大健康症状

方式监控处理，以提升病人健康。民众可以依照此六大健康症状来自我检查,连验血都不必.对于新诊断的糖尿病人，应尽可能转介到专门处理糖尿病 4.对于新的病患应该立刻转介中医,因为连前总统经国先生都

的医疗单位。已经被西医治死了,大家要学到教训,不犯二过.

加强注意糖尿病背后成因，包括积极治疗胰岛素阻抗性。5.现代糖尿病背后成因是疫苗与

抗生素,读者认为西药厂会说明吗?

积极治疗病患,以求在六个月内达到糖化血色素低于 6.5%6.真正能够积极治疗的是使用中药,西药怎么可以说是治疗呢?这里

的目标。在误导群众,混淆视听.

治疗三个月后,如果病患仍无法达到糖化血色素低于 6.5%7.民众找一位中医治疗三个月后,如果无法改善,就找另一位中医师

的目标,应考虑综合药物疗法。绝对不可以再加重使用西药控制.

患者在诊断出糖尿病时,若糖化血色素已大于 9%,应立 8.患者在被西医告知得到糖尿病时,应该转身去找中医治,同时停止

即采用综合药物疗法或注射胰岛素。止一切西药.

糖尿病的综合药物疗法,应选择作用机转互补的口服药。9.糖尿病中医可以治,越早越好,如果吃西药越久就越难治的.

以跨科际整合的团队进行糖尿病管理,鼓励病患教育和自 10.中医师应该随时充实自己,以便应付这些被西药厂搞出来的病患.

我照护,让患者与医疗团队一起担起血糖控制的责任。让全世界中医一起担起治疗糖尿病的责任吧.

资料来源:全球糖尿病有效管理同盟制表:薛桂文资料来源:美国汉唐中医倪海厦制表.

评论

上文红字部份是能够治好糖尿病的中医与不能治好糖尿病的西医所说的,之所以大异其趣,因为一个在真正治疗,另一个在想办法控制,所以当然持有不同的看法.读者自己去做出你们认为最明智的选择吧.

严控血糖糖尿病唯一救命丹【联合新闻网记者沈尚良 / 台南报导】

糖尿病被诊断出来时,体内分泌胰岛素功能通常只剩下一半左右,即使配合运动、饮食和药物控制,患者体内分泌胰岛素的功能仍会持续下降。不过,只要把血糖控制在理想范围内,就可减少或延后糖尿病并发症发生的机会,比不使用胰岛素导致血糖控制不良的患者,会有更健康的生活。(真是胡说八道,为什么不让中医治疗,中药绝对可以让病人有更好的生活质量,这病是可以治疗的.)

卫生署台南医院家医科医师毛恺民指出,有些患者基于一些个人理由,像是害怕西药副作用、害怕注射胰岛素会变成需要洗肾及注射胰岛素不方便等,而放弃口服降血糖药物和注射胰岛素,去选择一些另类或辅助疗法,包括微量元素、维生素、中药、针灸、草药和饮食疗法,甚至偏方等。(这总比吃西药好许多,有何不好呢?)

但他分析指出,草药和饮食疗法可能会因为是天然食品而容易被人接受,但天然食品不一定安全,而且有的食品含有糖类和淀粉类,多吃一样会使血糖升高。

而中医的中药和针灸都有其辨证理论,必须透过合格中医师诊治使用。至于补充微量元素和维生素,只是辅助性疗法,应依照一般人的建议量服用,过量摄取会有副作用产生。(这里替中医说话了,我很赞成.)

毛恺民特别提醒,如果患者要尝试另类疗法,不要断然停止西药,而且还需要定期监测血糖,配合医师的指示调整药物,把血糖控制在稳定理想的范围才是上策。(不需要如此做,只要吃对中药,病人可以立即停止西药.)

他提到,有位 58 岁的先生因食欲增加、容易口渴、体重减轻及疲倦而求诊,过去虽无明显病史,但检查后发现血糖值高达 250mg / dl。经由口服降血糖药物调整,将血糖控制在理想范围,患者觉得身体轻松许多。(这数字并不算高,但是病人一旦使用西药控制血糖后,胰脏就跟着同时退化了,于是终身受西药摆布,最多能控制约 20 年,而 20 年之后照样无法控制时,病人全身发肿,下肢瘫痪,此时打再多的胰岛素,血糖照样居高不下,然后死亡,前台湾总统经

国先生就是如此惨死于西药控制之下.)

后来患者听说有草药可治,于是开始服用草药,而停用糖尿病药物。两个月后再度出现口渴、小便增多现象,检查发现血糖已升到 280mg / dl,才又回复服用降血糖药物,症状才逐渐消失,血糖也回复正常。但持续规则服药、饮食控制和运动一年后,患者的血糖值又开始升高,即使口服药物调到最大剂量,依旧无法把血糖值控制在理想范围,于是改换成注射胰岛素,血糖再度回到理想范围。(草药不是正常中医在用的,读者千万不要将草药与中药混为一谈.)

糖尿病长期会引起神经、视网膜、肾脏和大血管病变,治疗时需改变生活和饮食习惯才能把血糖控制好,多数人还需要药物治疗。但研究也发现,使用口服磺胺类降血糖药物,每年有 5%~10%会治疗失败,最后仍须靠注射胰岛素来控制。(这不正确,这些病变都是口服降血糖药与胰岛素的副作用所造成的,并不是因为糖尿病才得到的.)

毛恺民表示,糖尿病是隐形杀手,如有高血压或高血脂就应做糖尿病筛检,至少三年筛检一次。一般人满 40 岁后,可以利用健保成人健康检查。

评论

糖尿病患者请注意,你们的医师开口服药片或是给你胰岛素针剂等,虽然可以暂时得到舒缓,但是后面却隐藏了极严重的后果,他不会跟你说实话的,一旦说出来,我保证没有人会再使用西药了,现在由我来说明给民众听,这些都是我真实的临床经验,很宝贵的。

第一:一旦你开始使用西药控制你的血糖之后,你的胰脏就开始退化,于是你就会越吃越多,越用越多,逐渐的你的双脚开冰冷,双眼视力出现问题,性功能丧失,身体过胖,越来越浮肿,头发开始掉落,体力越来越差,记忆越来越差。

第二:约只能控制你二十年,之后西药完全无法控制你的血糖时,你坐在轮椅上,双脚麻刺痛且肿,全身肿胀,视力丧失,听力丧失,肾脏功能下降,于是你开始洗肾,最多五年,但是还没有完成洗肾时,你的超高血糖照样会要你的命。

结论是:第一型糖尿病是因为打疫苗有些病人对疫苗无法适应而造成的,也就是说是西药厂制造出来的疾病,原本是根本没有这种病的,第二型糖尿病是饮食不规律,不节制造成,所以要改变饮食习惯,然后找中医治疗,就有机会恢复过来的。

日调查:多喝绿茶和咖啡可预防糖尿病

【中央社】

(中央社记者张芳明东京二十日专电)日本大阪大学研究小组的一项广泛并长期的研究调查结果显示,绿茶和咖啡具有预防糖尿病的效果,多喝可降低罹患这种疾病的机率。(这个研究小组必然有咖啡商在幕后提供资金,否则怎会将这两种风马牛不相干的咖啡与茶放在一起讨论,这就是障眼法.)

朝日新闻今天报导,由大阪大学公共卫生学教授矶博康率领的研究小组,对日本全国约一万七千名四十岁至六十五岁的男女进行长期的追踪调查而获得这项结论。(咖啡是酸性饮料,茶是碱性饮料,二者完全不同,所以这里的数字在骗人,他们认为没有人会去查证他们所说的数字是否真实,因此就信口开河.)

这个研究小组在文部科学省的经费援助下对未患有糖尿病、癌症和心脏病的一万七千四百一十三名四十岁至六十五岁的男女进行追踪调查,五年之间有四百四十四人罹患糖尿病。

调查研究显示,一天喝六杯以上绿茶者比每周不满一杯的人,罹患糖尿病的危险度减少百分之三十三,每天喝三杯以上咖啡者比每周不满一杯者则减少百分之四十二。(这两段都是研究人员在玩数字游戏,都是自己编的,民众不须要去信.)

调查研究并显示,根据身高和体重而被判定为肥胖者之中,经由咖啡或绿茶摄取较多咖啡因者,罹患糖尿病的危险度也大为降低。(这段在混淆视听,糖尿病病因与咖啡因无关,与酸碱有关,咖啡是酸茶是碱,二者都有咖啡因,这些家伙就利用咖啡与茶这个共同点在说谎,居然

硬将鸡与鸭说成是同一动物,真是会骗人.)

评论

读者千万不要上当,我们要多喝茶,不要喝咖啡,直到目前为止世上所有对茶的研究都是正面的,对于咖啡的研究都是负面的,因此咖啡商非常狡猾,利用一些没有良心的学者替他们说咖啡好,结果留下这一篇笑掉人们大牙的笑话,这就好像鸡与鸭完全不同,结果现在有些笨蛋自以为聪明,硬是将二者说成一样,真是遗笑千年的研究.

结论是:茶是给大家孝顺府父母亲用的,咖啡是送给你的敌人吃的,这已经很明确了,喝茶的好处无法说尽,大家去多喝吧.

糖尿病高血压没控制拖累肾病成台湾新国病【中央社】

探讨新国病肾病系列一(中央社记者陈清芳台北十八日电)台湾目前有五万两千人在洗肾,一年增加八、九千人,这种台湾的「新国病」耗费大量医疗资源,去年花掉新台币两百七十七亿元,除了归因于原发性的肾病变,更因为国人糖尿病、高血压没控制,使肾脏如最后倒下的骨牌。中央健康保险局依据美国肾脏数据输入系统(USRDS)二零零五年报告显示,台湾每年新增尿毒症的比例(发生率)为每百万人口有三百五十二人,高居世界第一位,全台湾人口的尿毒症比例(盛行率)为每百万人口有一千六百三十一人,高居世界第二位,仅次于日本。(读者看到此时,千万不要被误导了,这段中只有得病数字是真实的,致病原因是错误的,它误导了台湾百姓,这类误导百姓的言论,卫生署怎么不去开罚呢?现在你们的阿扁居然没有任命监察委员,所以当官的就可以乱说话,洗肾并不是因为糖尿病与高血压没有控制好而造成的,真正原因是因为病人去吃西药来降血糖降血压所造成甚衰竭,因此可以说是病人因为吃西药肾脏中毒所导致的.因此这一段是在粉饰太平中.读者有空时去洗肾中心问一下洗肾病患,他们到底是怎么会来洗肾的,我来告诉大家,其中一半是因为服用西药止痛药造成甚衰竭,另一半就是服用降血糖药物与降血压药物造成肾衰竭的.当然有少部分是服用有毒草药造成,都跟中药无关的.)

健保局医务管理处副理林阿明表示,随着洗肾人数增加,使用的健保费用逐年上升,但洗肾病患的住院率、死亡率、腹膜炎并发症等指标,都有改善的空间。台湾肾脏医学会统计,引起慢性肾衰竭的主要病因以糖尿病、慢性肾丝球炎(肾脏本身病变,例如感染造成)、高血压最多;理事长黄秋锦指出,换言之,如果国人的糖尿病、高血压能控制良好,洗肾的年增率就会趋缓。台湾的糖尿病患者约有一百万人,国家卫生研究院追踪基层诊所的病患研究显示,即使以糖化血色素值八(代表近三个月的血糖控制情形)的宽松标准检视,在基层就医的糖尿病患者,有半数控制不好,这类患者多为六十岁以上、低教育程度。国卫院助理研究员许志成表示,欧美建议糖尿病合并高血压的病患,血压控制在收缩压一百三十/舒张压八十五毫米汞柱以下,但即使以一百四十/九十的宽松标准来说,台湾糖尿病患者血压控制不良,发生糖尿病肾病病变的风险,是血压正常糖尿病患者的二到三倍。(这段错误百出,其中包含一位昏官二位庸医,由于他们正在误导群众,为了保护百姓健康着想我必须挺身而出,真正造成洗肾的原因是因为病人服用这些控制性的西药所导致的结果,而糖尿病与高血压是可以治疗的,目前只有中医可以做到,下面就是我提供给读者的证据,证明中医是对的.)

中华民国糖尿病卫教学会理事长蔡世泽说,肾丝球的构造像一团毛线,糖尿病造成的血管病变会伤害肾丝球,于是病患的尿液中会出现蛋白质,随着病程恶化,接下来血压升高,肾脏不但是调节血压的一个器官,高血压也会透过内分泌系统,火上添油,损害肾功能。(这段又出现一位庸医加入声援上段的庸医们,现在是四人对我一人,这些人在粉饰太平,他们都不希望人民健康,他们一直鼓励人民吃西药,就是因为如此,所以才造成今天如此多的洗肾人口在台湾,这些人还不检讨检讨自己的过失,居然还在大放厥词,继续在做伤天害理之事.洗肾人口每年上升中,这就已经代表现在发扬的医学是错误的,居然还在蒙骗人民.)

健保局统计亦显示,高血压门诊病患一年用掉一百零六亿元的降血压药,且昂贵用药处方

率超过六成,但是,血压控制率却只有四成。(这数字说明其中有太大的利益在里面,读者看到这数字就应该知道他们为什么昧着良心做事,昧着良心说话了,那么多钱在里面,他们当然不要病人被中医治好,病人好了,他们玩什么呢?)

糖尿病、高血压和肾脏病都是不可逆的疾病,而且小血管、心血管、肾脏像推骨牌一样倒下,病患与日俱增,健保局目前持续推动糖尿病、高血压、洗肾的论质计酬方案,以支付制度奖励及约束医师提高照护质量,并加强对病患的卫教,就是希望台湾不要成为「洗肾王国」!(什么叫做不可逆的疾病,明明是可以治疗的,结果可以治病的中医学不被重视,害人的西药却被宣扬,其中只是为了赚黑心钱,这种钱可以赚吗?小心你们这些昏官与庸医将来你们的子孙会因此得到报应的.)

评论

这篇都是在宣扬西医药,连台湾卫生署的官员都混迹其中,现在开始我用真实病例纪录来证明给读者看,到底是在替百姓维护健康?还是我在误导百姓?由于这篇报导实在太离谱,已经可以说会动摇国本,台湾继续如此相信西医药下去,将来必然会亡国的,因此我有必要跟读者们说清楚,讲明白,这里我附上一张病人自己制作的诊疗实录,他在来找中医之前,已经服用西药控制血糖跟高血压四年了,这四年来他的体重一直上升,人疲劳倦怠,上班精神无法集中,性功能一直下降中,记忆衰退,肌肉关节疼痛不已,今年一月十六日经友人介绍来此看我之后,他从一开始就按时纪录服用中药后的血糖与血压的变化,由于他是我所有这类病人之中数据做的最详细的病人,所以我将之贴出来给读者看,这种案例每天都发生在我这,毫不足奇,他只是其中之一位,自从他停止服用西药降血糖与降血压后,读者看看最右第二行记载他的体重变化,可以看出自开始至今他少掉 30 磅体重,我是他的主治医师,我发誓我从未给他任何中药减肥,他之所以瘦下来是因为我从一开始就要求他停用西药的关系,读者可以看到此人的血压逐渐下降,血糖也逐渐下降,脉搏也依样的降下来,直到现在已经完全恢复正常了,最右边的胆固醇数字稍微超过 200,这表示此人完全无癌症,这是绝对的直接证据,证明病人已经好了,上面的一位昏官健保局医务管理处副理林阿明与三位庸医台湾肾脏医学会理事长黄秋锦及中华民国糖尿病卫教学会理事长蔡世泽加上国卫院助研究员许志成你们四人看到中医治疗这病人的纪录,你如果是此人,你做何感想?你如果有良心的话,你会继续将无辜的百姓推入万劫不复的终身服药地位,而结果就是洗肾,直到有一天连洗肾都无法洗时,病人就坐以待毙,这是你们所追求的目标吗?如果是,那你们就是走对路了,如果不是,你是真正替百姓健康着想的圣臣,你是有良心的良医时,当你看到下面这病人用你们都懂的西医学做的中医医疗纪录时,你还能否定中医无效吗?如果你还是否定,那你就是睁眼瞎子,你在图利西药厂的同时,也在粉饰太平,倒霉的就是百姓,洗肾的也是百姓,你们赚取这些黑心钱,将来会报应在你们的子孙身上的,中医五千年的经验,不会因为你们的打压而消失,它仍然将会主导世人的健康,它的光芒不会因为你们而消失的.

如果这三位医界人士跟这位昏官看到后,觉得仍然不够说服你们,请来函告知,我多贴些给你们看,我太多存盘了,随时欢迎你们来看,请记住一大原则,我也当过州官,我认为只要对百姓有利的,我们就该去做,你们说对吗?你们都赞成吗?

结论是:真正害人去洗肾的不是糖尿病跟高血压,而是那些控制血糖与控制高血压的药物所造成的,而第一类糖尿病是因为西药厂的疫苗造成的副作用,原本根本就不存在的病,高血压是症状不是病,只要找到病因就可以治疗,完全不需要西药来控制.请西医拿出你们的良心来,跟百姓说实话是一定受到尊重与赞扬的.要留芳百世还是遗臭万年,你们自己做决定吧.

读者记住一点,今天还好我在美国开业,如果我在台湾开业的话,他们就会来找我麻烦,结果是说真话的我被他们硬说成打不实广告,而欺骗民众的西医与西药厂却是被鼓励的,这种颠倒是非的事,时常在发生,因为你们的卫生署是西医开的,所以他们只保护西医,不保护人民的.

常喝咖啡的人较少糖尿病

更新日期:2006/11/03 07:00 记者:编译朱邦贤 / 路透纽约二日电

最新研究结果显示,常喝咖啡的人罹患糖尿病的机率要比不喝咖啡的人低得多。(他们没有做胰脏癌的研究,所以至今仍然不知道胰脏癌是怎么得到的?)

圣地亚哥加州大学的贝莎·史密斯和同事在报告中指出,就连在曾经爱喝咖啡的人身上,也有这种奇效。

史密斯在接受路透访问时表示:「越来越多的文献明确而且强有力的指出,这和咖啡里某种东西有关。」她说,到底是什么东西并不清楚,但大概不是咖啡因,因为无咖啡因的咖啡同样有效。(这又在替咖啡商做宣传,真是要命。)

史密斯和她的同事调查了九百一十名男女,研究开始时,受访者全都超过五十岁,而且都没有糖尿病。大约八年以后做追踪调查时,曾经爱喝咖啡或当时仍常喝咖啡的人,罹患第二型糖尿病的机率比不喝咖啡的人低了百分之六十左右。(第二型糖尿病跟吃宵夜与少运动有关,跟咖啡无关的,真是在胡说八道。)

糖尿病大致可分为两种,第一型糖尿病是一种自体免疫疾病,多半在青少年时就会发病,跟遗传有密切关系。约九成至九成五的糖尿病属于第二型糖尿病,又称为成年型糖尿病,通常发生在四十岁以后。(第一型糖尿病是因为病人对B型肝炎疫苗产生过敏,于是胰脏因此而失去功能,无法再替人体生产胰岛素,所以第一型糖尿病是西药厂所制造出来的疾病,原本是根本不存在的。)

研究人员将运动、体重、血压、吸烟、性生活等因素考虑进去,仍然看得出常喝咖啡降低第二型糖尿病罹患率的功效。甚至对研究开始时有葡萄糖失耐现象(糖尿病初期警讯)的人也有效。(这又在骗人中。)

至于到底要喝多少咖啡才能产生这种功效,研究人员也无法断定。史密斯说,接受调查者一般而言咖啡喝得不凶。(这里又说无法断定,前后是矛盾的说词。)

史密斯和同事获致结论:「鉴于肥胖、葡萄糖失耐和糖尿病的情况日益普遍,多数西洋社会大多数成年人又有每天喝咖啡的习惯,咖啡的益处可能产生广泛的影响,进一步研究有其必要。」(如果是真正有良心的学者来做研究,立刻就可以发现我说的咖啡是导致胰脏癌的主要原因是绝对正确的。)

评论

这种胡说八道的研究,根本就是在替开咖啡商护航,完全无视于人民的健康,这种学者必将受到唾弃的,真是没有良心的一群人。

印度瑜伽治疗初期糖尿病疗效媲美药物治疗

更新日期:2007/02/28 18:53

(中央社记者郭传信新德里二十八日专电)国际糖尿病联盟去年十二月公布数据显示,全球糖尿病患者达两亿四千六百万人,其中印度人高居首位,中国人第二,而且直到二零二五年,两者糖尿病患者人口都将名列全球前茅,因此,印度专家最近实验以瑜伽术治疗初期的二型糖尿病患者,成效媲美药物治疗,值得参考。

二型糖尿病又称成人糖尿病,特点是胰脏不能产生足够的胰岛素来控制血糖浓度,或胰岛素的细胞没有回应。当细胞没有回应,又称「抗胰岛素现象(insulinresistance)」。差不多百分之九十至九十五的糖尿病人是二型患者,多属过胖者,通常在四十岁左右发病,但近年也有更年轻者,发病时伴随着高血压、高血脂等疾病。

最新一期的「印度内科学会」杂志,刊登了一篇由印度南部舍奈M. V. 医院糖尿病科联合主任维斯万纳旦(Dr.VijayViswanathan)和舍奈医疗保健中心首席医师查可

(Dr.P.T.Chacko)合作进行的瑜伽术治疗糖尿病研究报告。

报告说,将十名血糖浓度接近正常的二型糖尿病初期患者,分成两组,一组只给予治疗糖尿病的药物「二甲基降糖灵」如Methormin治疗,另一组则只练习瑜伽体式。

此外，两组同时也采取正规的生活作息，包括控制饮食和进行瑜伽之外的运动等，观察期达六个月之久。

维斯万纳旦在报告中表示，六个月之后，药物组病人的血糖浓度和体重都降低了，但瑜伽组病人的血糖浓度和体重也降低了，但更重要的是，瑜伽组病人的「胰岛素敏感性（insulinresistance）」也获得了改善。

在前后六个月的观察过程中，研究小组采用「稳态模型评估法

（homeostasismodelassessment）」计算两组病人的胰岛素抵抗指数。

瑜伽组志愿病人之一的维木鲁钢表示，他的血糖浓度从去年九月的百分之九点三，到今年二月已降低到百分之五点九，同时体重也减轻了五公斤。

不过，维斯万纳旦也强调，这只是初步的研究，而且观察人数也只有十人，只能说是一种概念研究的证实。他说，瑜伽组病人的血糖和体重双双降低，是否要完全归功于勤练瑜伽术，或是也归功于生活作息的改善，目前尚言之过早，仍需要更多的人参与实验。

但维斯万纳旦指出，这项初步研究旨在比较瑜伽术和常用糖尿病药物的治疗效果，而成果显示瑜伽术的疗效也相当药物，证实治疗糖尿病不一定要依靠药物，只要勤练一些瑜伽体式，就可以获致与药物相同的疗效，同时也证明瑜伽不再是治疗糖尿病的辅助疗法，已经可以取代药物。（这篇报导的最后一段就是重点所在，中国的功夫一样可以做到这种阶段，还有用西药控制血糖只是越用病就会越重，死亡时连双脚都被切除了。）

评论

第二型糖尿病是因为饮食生活习惯不正确所产生的，民众只要多多运动，多吃有机食物，不要吃含有人工添加物或是改良过的食物，过胖的人就要减肥，不可以懒惰，这些做到，血糖自然就下降。

糖尿病药致心脏病无定论病患勿擅自停药

（中央社记者陈清芳台北七日电）治疗糖尿病的罗格列酮胰岛素增敏剂是否会增加心脏病风险，现在成为跨国药厂与美国食品药品监督管理局争辩的焦点。药厂送交卫生署审查的文件早已加注相关警语，目前病人应与医师讨论用药，不宜贸然停药。（这段说明了西药厂已经承认这种药物会致心脏病，不然为何要加相关警语？）

今年五月底的新英格兰医学期刊披露研究指出，俄亥俄州克里夫兰诊所心脏病科医师尼森汇整分析四十二件临床试验，发现胰岛素增敏剂「梵帝雅」会增加百分之四十三的心脏病发作率。（现在连美国西医都在骂西药厂了。）

生产「梵帝雅」的葛兰素史克药厂在六月初的新英格兰医学期刊上，刊出对四千四百四十六位病患的四年临床研究初步结论，指出长期服用梵帝雅不会增加心脏病或死亡的机率。（这些西药厂是全世界最恶质的魔鬼，他们专门打击对他们不利的人或事。）

截然不同的研究成果，在美国众议院的听证会上，引起葛兰素史克药厂与美国食品药品监督管理局(FDA)的争论，目前美国官方尚未决定要求药厂在「梵帝雅」加注「最重警语」。（因为所有美国现在在台面上的政治人物，其背后最大的政治献金来源就是西药厂，所以就算FDA要找他们麻烦，还是很困难的，何况我是一个人呢？）

台湾已核准含有罗格列酮的药品，共有「梵帝雅」、「梵帝美」与同类型的「爱妥糖」等三种，一年大约有十五万的病人使用，药厂送交卫生署审查的仿单(说明书)，早已规范三、四级的重度心脏衰竭与肝功能酵素指数大于正常值二点五倍的异常者不应使用。（我早就跟读者说明过，真正引起心脏病的不是高血糖，而是控制血糖的药物，连使用这种药物的台湾西医可能都不知道，因为他们不懂中医的诊断手法，而西药的副作用我是一查就知。）

台北荣民总医院新陈代谢科主治医师蔡世泽表示，糖尿病未获控制时，心脏病的风险升高，所以胰岛素增敏剂是否会造成心脏病风险，还很难说。由于胰岛素增敏剂的药价较高，通常在患者使用两种药物仍未能降血糖时，才追加此药，现在病患应与医师讨论，切勿擅自

停药，以免血糖失控。(这位西医就是不明白高血糖不是导致心脏病的真正原因，而是控制血糖的药物造成的心脏病，所以才会如此说，读者不要听他说的话，你们跟西医讨论，根本就是在与虎谋皮。)

评论

我不知已经说过多少次，真正引起心脏病的是西药，不是原来的病，降血糖药物只是其中之一而已，中医认为心为君主之官，本不受病，而西药中像抗生素、止痛药、抗忧郁药、安眠药、减肥药等等无法尽数的药物都会引起心脏病的，这种问题西药厂是心知肚明，但是他们怎么会笨到说出来呢？他们崇拜的不是神，而是希望大家都生病的魔鬼，读者看上面的报导就可以知道，连一个国家单位都无法将其一种药物去除你们就应该了解他们有多强的势力，不将之摧毁，难道就任其继续害人吗？读者可知道，我每次看到病人因为药害而失去宝贵的生命时，我心如滴血，眼泪只能往肚里吞，心中暗自发誓，必须将此獠消灭，否则人类将永无宁日。

这种药物的副作用，我非常清楚，举凡中医师只要有正确的真正中医诊断手法与观念，就可以看的很透彻，如此简单的问题是无法瞒过我的，我想随便一位民间的中医都可以查到的，当读者逐渐了解到西药厂是如何可怕后，就会体会我为什么要想尽办法将之消灭，要消灭它们，甚至光靠一个国家机构还是无法做到的，我将在人纪结束后，开始进行地纪的规划与撰写，读者不要害怕西药厂，因为真正治病的方法都将出现于地纪之中，当生命是真正的可以掌握在你们自己的手上时，你们就无惧于疾病，当所有人民都没有来自疾病的威胁时，我就赢了第一战，地纪将是一部列车，我启动此列车后，它将一直行驶到我生命的极限，人的一生赚钱方式很多，但是绝对不可以像西药厂使用这种害人的手段来赚钱。我一生从不愿向人挑战，如果温病派中医在人纪结束后，还是我行我素，不改正你们错误的中医学理论，同时还在继续误人子弟，灌输中医院校的学生错误的温病中医学说时，我将履行我的说过的话，人纪从开始到结束一共耗时二年半，希望你们这批广大温病派中医在这段时间中多多研读经方，用之造福人类，今年人纪将结束了，如果你们还是执迷不悟，我跟我的学生将向你们挑战，希望你们赶快觉醒过来，立刻改变成经方家，否则你们会无地自容的。

结论是：但问世间情是何物？唯真唯诚而已，我错当医师这一行，也因为此生走错道路，被我遇到这世上罕见的庞然大怪物，我不挺身而出，谁又能做到呢？如果人真的有来世，我但愿不要再当医师了。

糖尿病降血糖更危险？

更新日期:2008/02/08 04:09

降低血糖反而提高死亡机率

(编译罗彦杰 纽约时报七日报导)数十年来，科学家相信，如果糖尿病患者将血糖降至一般水平，就不再会是心脏病猝死的高危险群。但美国联邦政府所属的国家心、肺暨血液研究院针对逾一万名中年以上、患有第二型糖尿病的民众所做的一项大型研究，却发现降低血糖事实上反而提高死亡机率。研究人员因此宣布，决定紧急暂停部份的研究，因为此一令人震惊的结果挑战了糖尿病的治疗方式。(每次当西医自己做研究，却发现自己错的时候，都会立刻停止继续研究下去，因为会证明西药厂在骗人，西医学是错误的。西医学都是昨是今非，之所以会这样，就是因为西医学都是片段的研究，所以就会出错，中医学是全面的对人体做探讨，因此从不出错。)

这项结果不代表降血糖毫无意义。降血糖能避免罹患肾脏病、失明与截肢，但新的研究发现却使得过去认定血糖愈低愈好及降血糖至正常水平能提高存活机率等金科玉律受到质疑。医学专家都大感震惊。进行这项研究的研究人员强调，糖尿病患者仍应先向自己的医师谘商，然后才考虑改变其用药方式。(这句话就在害人了，西医师并不接受任何研究证明他们

过去是错的研究，因为他们无法承受这种打击，会造成他们一夜间全部失业的。数十年来的胆固醇过高会造成心脏病，也是西医学的金科玉律，结果现在呢？错误的医学知识，已经造成无数的笨蛋冤死，西医师还在狡辩，真是不知廉耻，丢人现眼。这段中所谓的降血糖能避免罹患肾脏病、失明与截肢，根本就是胡说八道，糖尿病病人如果不使用西药来控制血糖的话，根本就不会出现这些问题，这些所谓罹患肾脏病、失明与截肢，是来自降血糖药物造成的副作用，跟糖尿病无关。)

研究结果颠覆传统治疗方式。(西医学都是昨是今非的医学，中医学五千年来都不需要去做改变，因为中医学是真理。)

主张低血糖的学理根深柢固，大多数人都认定血糖愈低愈好，但从来没人严格验证此一说法。所以这项研究要问的是，如果第二型糖尿病患（占全部病患的九十五%）的血糖量很低，是否能免于得心脏病与增加活命机会。(数十年来这错误的观念已经不知害死多少人了，西药厂是否该赔偿呢？真烂。更严重的是第一型糖尿病是因为疫苗引起的，他们还隐瞒着。)参与这项研究的患者，是以随机方式指定降低血压至接近正常水平，结果密集降血糖组与未严格控制血糖水平的对照组相比，多出五十四件死亡案例。研究人员立刻中止密集降血糖的疗法，改以较温和的治疗方式。这些患者加入研究的时间，迄今平均为四年。(按照西医学的标准，正确答案都已经出现了，但是已经因此而赚尽全世界人民钱财的西药厂，会罢手吗？这些既得利益者，绝对会想尽一切办法来打击这类研究，否则他们就完蛋了，这就是我时常说的西药厂只管自己赚多少钱，从不管民众的死活，它们的药都让人更短命，又无效于治病。)

执行这项计划的赛门斯莫顿博士说，他们本来怀疑是否有任何药物或合并用药造成患者死亡率提高，但后来发现不是；就连被怀疑会增加糖尿病患心脏病死亡机率的药物

Avandia，在研究中也并没有造成这种效果。(这里又错了，西医没有寒热的观念，这些降血糖的药，在人体内会造成里寒，就是里寒才引起心脏病与中风的，他们不知道啊。)

医师主张仍应努力控制血糖(这研究都已经证明西医对糖尿病的认知是错误的，居然还有西医师死皮赖脸的死不认错。这也说明了西医师根本不管病人死活，只管他们的面子问题。)

威斯康辛大学糖尿病专家赫许博士说，这项结果很难说服那些花了好几年且透过饮食与服药来降血糖的患者，「他们不会想就此松懈」，「要这些患者提高血糖将难如登天」。(这里又在乱说了，要病人相信很简单，只要告诉每位西医，过去的研究完全错误，大家必须立刻停止使用降血糖药，否则就会死得更快，如果所有西医都这样对病人说，病人绝对会停止继续使用下去，怎会难如登天呢？正确说法应该是要求西医师来做这件事，是难如登天，这就对了。中国有句俗话说，牛牵到北京还是牛，就是说笨蛋就是笨蛋，到哪都一样还是笨蛋。)

(记者田瑞华台北报导)耕莘医院新陈代谢科主治医师裴昶表示，国内的糖尿病患普遍血糖控制仍不够良好，很难达到正常血糖值，因此不可以看到这项研究发现就松懈控制血糖。而且，在这项研究结果获得进一步讨论和更多研究证实之前，糖尿病患仍应该遵照医师指示，努力控制血糖比较好。。(当一位优良的医师，必须随时自己求进步，不是依靠别人的研究在执行，此医不知自我求进步，过去完全依赖国外的研究，而今国外的研究已经说明过去是错的，而此医却不更正，还在继续要求病人控制血糖，继续在害人早死，台湾的西医水平如何，民众可想而知。)

评论

数十年来我不断的一直在骂西医学所谓糖尿病的研究是错误的研究，这个错误的研究再加上错误的使用西药来控制血糖，于是雪上加霜，病人花费许多冤枉钱来买药，结果却是越治越短命，我一直用台湾的前总统经国先生为例子来证明西医学是错的，大家有听吗？笨蛋还是笨蛋，还是继续使用西药来控制血糖，现在这篇报导说明了，降低血糖所造成的生命

风险，比药物的副作用还恐怖，让病人死的更快，大家看看，这就是你们相信的西医学，我骂你们笨，是想救你，生命是宝贵的，相信西药厂就是跟魔鬼打交道，你只有死路一条，毫无生机，。

中医对糖尿病的看法很简单，我们称之为消渴，病人如果口渴又尿多，饮水一杯就小便一杯的症状出现时，我们只需使用一些能生津止渴的药物就可以治好这种症状，同时替病人做检查，看身体内失去平衡的原因是什么，然后替病人做全身的调理，于是病人自然就恢复正常了，这是非常简单治疗手法，一般中医应该都会，经方中的桂附八味丸就是为此而设计的处方，当然还有其它的处方可用，因人而异，至于高血糖会引发心脏病与中风，根本就是胡说八道，真正会引起心脏病的是西药与硬降血糖造成的，因为被降下来的血糖，并未离开身体，而是停积在双脚上，于是造成下焦寒湿，而下焦寒就是制造血块的来源，这才是真正造成心脏病与中风的根源所在，简单说就是如果你的双脚是温热的，就没有机会得到心脏病与中风，如果是冰冷的，就非常容易得到心脏病与中风，经方中的芍药甘草附子汤就是为此而设计出来的，因此这处方就是最好的能够预防病人得到心脏病与中风的最优经方了。

下次有机会再跟读者们多聊些，现在只有一句话说，就是祝大家新年快乐，所有现在被西医视为金科玉律的理论，都有问题，何止只是高血糖呢，西药厂真是烂啊。

注射胰岛素伤肾伤眼？坊间错误观念

更新日期:2008/06/29 04:09

文陈品泛

糖尿病患者需要「斤斤计较」血糖的控制，一旦控制不好，可是后患无穷。只是当吃降血糖药效果不彰，而经医师建议，要注射胰岛素时，许多糖尿病人的心情顿时会往下沉，以为注射胰岛素会造成肾脏或眼睛的伤害。其实，这只是民间口耳相传的错误观念。(这位西医错了，严格控制血糖才是造成伤害肾脏与眼睛的元凶。)

根据国外相关研究指出，注射胰岛素并不会伤害身体，并且能快速有效的控制血糖。(又错了，最新国外研究不是这样说的，最新研究是越严格控制血糖却使病人越短命。)

糖尿病患者如果血糖失控，包括眼睛、肾脏、神经以及大血管等，都有可能产生严重病变。现在对于糖分控制的目标都很清楚，空腹血糖要在 130mg/dl 以下，饭后两小时的血糖不要超过 180mg/dl，不管吃药或是用胰岛素，只要能把血糖控制好，就能减少对身体器官的伤害。不过，糖尿病的进展是胰岛素细胞逐渐变坏的过程，除了透过持续加药控制外，当口服药量到达极限时，就必须仰赖胰岛素注射，使血糖控制在目标值内，也就是早期使用胰岛素。(这样越做越坏，只会让病人更短命，应该立刻找中医师来治疗糖尿病，而不是加重使用西药剂量来控制血糖。)

胰岛素是由胰脏制造的一种荷尔蒙，能让葡萄糖进入体内，提供热量。当胰脏无法制造足够的胰岛素，会导致葡萄糖无法充分进入体内，血糖浓度就会升高，便会形成糖尿病，因此使用胰岛素来控制血糖是再自然不过的。(非常的不正确，医师应该研究如何让胰脏恢复功能，而不是使用药物来替代胰脏的功能，使用控制药物这样的做法，只会让胰脏退化，终至完全失去功能而提早死亡。这种说法是来自西药厂，不是医师本身的研究。)

对于注射胰岛素的问题，国外的糖尿病人担心的是打针会痛、不方便，以及血糖过低；至于国人则是担心会伤害眼睛和肾脏，其实这是不应该担心的事情。但是当医师建议施打胰岛素时，表示体内的胰岛素细胞已经变差了，必须要赶快接受胰岛素治疗，让血糖在最短的时间内获得控制，才能预防眼睛和肾脏被糖分伤害。(所有的西药都会伤害肾脏与肝脏，这已经是不争的事实，肝主目，伤害肝脏就会伤眼。)

现在最新的治疗观念是不管过去的血糖控制有多糟，眼前就是要想尽办法在 3 个月内，将血糖控制在理想的范围内，这样对未来糖尿病的控制才是最有保障的。(这段又说错了，最

新的观念就是越控制血糖命就越短，所以最新的观念应该是利用中药将糖尿病治好才对。) 要在 90 天内做到并不容易，重点是要配合饮食控制、每月定期就诊由医师调整药物，必要时，必须及早使用胰岛素，当达到标准血糖后，再减药，这样就能有效控制糖尿病。(这段没有说完整，病人除了控制饮食之外，应该多多利用运动来消耗体内糖分，吃中药来将胰脏恢复功能，这才是能长寿又健康的唯一选择。)

(作者为大林慈济综合医院新陈代谢科医师)

评论

人类会生病就是因为祸从口入，所以糖尿病只要知道正确的饮食方式，就可以改善体内血糖的量，一旦出现问题时，如口渴无法控制，食不知饱，等消渴症状出现后，就立刻找中医来治疗，不用去验血，病人只要能正常吃喝，能安睡，双足发热，体力正常，就是常人，每个人都需要多多运动，多多出汗，这才是真正的健康之道，如果只去思考如何控制血糖，而不去修正生活与饮食方式，任何人都会生病的，如果读者按照上篇报导中西医所说的方式来做，你一生就会被西药控制，到后来西药无法继续帮你控制血糖时，你就走人了。现在美国与台湾都有上万人正在洗肾中，绝大多数都是因为使用控制血糖药物后引起肾脏衰竭，于是终生身洗肾，所以只知如何使用西药来控制血糖而不知如何将糖尿病治好的医师是不行的，最新的研究应该是如何将病治好，而不是用控制的方式才对。

他半夜梦游原来是…血糖太低

更新日期:2008/11/11 16:00 记者李树人/台北报导

血糖要是降得太低，可能导致梦游！一名罹患糖尿病的中年男子最近半夜起床，在屋内没有意识地走动，吓坏了家人，最后找到原因，原来是因服用传统降血糖药物，造成血糖降太低，才会造成半夜梦游。

糖尿病专科医师游新表示，控制血糖是治疗糖尿病患者的主要目的，有些患者服用传统降血糖药物之后，因为东西吃太少，加上药效发挥，胰岛素不停地分泌，以致出现头晕、发抖、神智不清，甚至梦游等症状。

「好饿！」游新表示，有人血糖太低时，会出现极饿的情况，拼了命，都想吃东西，或是饿到发晕。就算在睡觉，也会被饿醒，一定要立刻吃东西，否则大喊大叫，宛如丧失理智。

该名梦游的中年糖尿病患者，平常服药情况正常，血糖也控制得不错，最近好几次在夜里出现梦游，睡到一半，突然爬起来，到处走动，太太叫半天，也相应不理，病患根本不晓得自己晚上会没有意识地趴趴走。

由于担心梦游可能危及健康，该名患者到神经科就诊，接受了脑波检查，结果正常，找不出原因。几天后，他突然晕倒，被送至急诊室，才发现原来血糖太低，血糖值只有 16mg/dL。

游新表示，正常人饭前血糖值(mg/dL)约在 40、50 至 90 附近，16 实在太低了，白天可能还没有异状，到了晚上，体内血糖太低，才会导致患者梦游，吓坏了家人，在换药之后，血糖不再偏低，就不再梦游了。

游新指出，近 10 年来，降血糖药物的研发相当快速，新一代的口服降血糖药物「DPP-4 抑制剂」，一天服用一颗，可以帮助延长肠道荷尔蒙停留在体内作用时间，强化身体自身血糖调节能力，病患接受度高。虽然目前健保还没给付，需自费，却是第 2 型糖尿病病患的治疗新福音。

游新认为，治疗糖尿病需要一个良好的医疗团队，包括医师、护士、卫教师、营养师等成员，都要有耐心地给予病人正确的卫教观念；病患用药后，如果产生副作用，医疗团队应提供协助，必要时调整用药，如此才能帮助病人获得最妥善的照护。

糖尿病患者热水泡脚 20 分两脚溃烂坏死

更新日期:2008/11/28 13:35

天气冷飕飕，糖尿病患者泡汤泡脚，要特别注意。一名家住南投的中年女性，有十多年的糖尿病史，前阵子，寒流来袭，在家用泡脚机，舒服二十多分钟后，脚背起水泡，自行擦药半个月没好，还严重溃烂，到台中医院求诊，发现是深二度烫伤合并皮肤坏死，差点要植皮，经过清创手术和十次高压氧治疗，总算康复。(这就是使用西药控制血糖的后果。)(寇世菁报导)

这名四十多岁的李小姐，有十多年糖尿病史，平时靠注射胰岛素控制血糖，最近寒流来袭，向邻居借了一台泡脚机，想在家舒舒服服的泡个脚、享受、不料，泡脚二十多分钟，两脚脚背起了大水泡，自行擦优典治疗，半个月下来，不但没好，脚部皮肤溃烂，紧急到台中医院求诊，外科医师陈明泽发现，伤口以经是深二度烫伤合并皮肤坏死，经过伤口清创手术以及十次高压氧治疗后，总算不用植皮顺利出院。(伤口无法愈合，两周不好，深二度烫伤。情况复杂，用高规格方式处理，差点要植皮，来时担心，怕被截肢。特别提醒糖尿病患者，神经病变不知道，不觉疼痛，泡热水泡太久不知道，只泡二十分钟，不觉得痛，水温四十多度，两脚脚背都起水泡，到医院住院一周，约一个月恢复)(西药厂制作的胰岛素最坏，就是这种胰岛素让糖尿病患者的血糖囤积在双脚，于是才会造成下肢血液循环不良，因此才会出现这种后遗症。)

陈明泽医师提醒，糖尿病患者如果产生神经病变，感觉都会变得迟钝，受到伤害，还不觉疼痛，另外糖尿病患者的伤口很容易发炎也较难愈合，如果受伤后又不懂得伤口照顾或及早求医，后果往往超出病人本身想象，像李小姐到医院后，听到可能要植皮，也吓了一大跳，呼吁糖尿病患者要以保护自己的常识。(当年台湾的前总统蒋经国先生就是因为这种问题而被截肢，死亡时双腿已经没有地方可以再切除了。而他并没有用热水泡脚啊。)

错误的医学观念

使用西药控制血糖越久，双脚就越麻木，一旦有伤口出现，就很难收口，如果无法收口，西医这时就会要求病人截肢来保命，真是越治越坏，我还有许多病人使用胰岛素多年以后，出现肝硬化与肾脏衰竭的现象，真正是在找鬼来治病。

有糖尿病问题的民众，请找正统中医来治疗，越早治疗效果就越好，拖延时日就比较难治，但是只要病人相信中医，还是可以治疗的，根本就不需要使用口服锭剂或是注射胰岛素来控制血糖，吃中药再配合多运动，同时改变饮食习惯，哪有不好的道理呢。

上篇报导中的中年妇女，就是因为使用胰岛素后，双脚才会感觉迟钝，如果从一开始就吃中药来治疗糖尿病的话，怎会有今天的状况发生呢?真正是被错误的西医学害惨了。

本土研发糖尿病新药商机无限

更新日期:2009/04/18 04:09 <http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/090418/78/1i1ok.html>

(记者魏怡嘉 / 台北报导) 本土糖尿病新药研发有重大突破! 国卫院成功研发出「新化学药物组合」的糖尿病新药—脯基双胜?? (DPP-IV) 抑制剂，可以增加第二型糖尿病患者(非胰岛素依赖型)对胰岛素的敏感度，降低血液中的血糖浓度。(为何不去研究，如何选用哪些中药来将糖尿病治好呢?)

国卫院与六大药厂合作开发(台湾的国卫院怎么没有跟中医师合作，开发出最好的治疗糖尿病的中药呢?)

国卫院已与国内六大本土制药厂产业联盟共同开发此药，并于明年底在台北荣总进行人体临床试验，预计二〇一七年前后上市，届时将成为台湾专利的糖尿病新药。(这些研究人员一天到晚就是在想取得专利，然后赚大钱，可有人关心病人的健康呢?)

计划主持人、国卫院生物技术与药物研究组主任赵宇生表示，糖尿病已名列全球死因的第四位，根据统计，二〇二五年将增加到三亿人。逾九成五患者属第二型糖尿病，主要为胰岛素抵抗性及分泌异常所致，绝大多数病患需要依赖口服降血糖药物，或是注射胰岛素来

控制血糖，迫切需要研发耐受性高、副作用低的糖尿病新药。(真正迫切需要的是中药，而不是再研发出新的西药，这就是继续在恶性循环。)

国卫院在上百种药物当中，找出治疗第二型糖尿病最佳的化学药物组合，代号为 DBPR108。

目前已核准上市的两个第二型糖尿病治疗新药，分别为美国默克（Merck）药厂的 Januvia 及诺华（Novartis）药厂的 Galvus。赵宇生表示，经动物实验发现，DBPR108 在胰岛素敏感度上的表现，均较现有两种药物好，此化学药物组合也已先后拿到美国、欧洲、日本及韩国的专利。

国卫院主任秘书江宏哲表示，新药开发往往需要十到十五年，是具有高风险及耗时、耗投资的产业，如果只由药厂去承担，风险相当高。(读者看到此人居然说出这种话来，他只关心西药厂的利益，如何保护西药厂，从没有真正关心过糖尿病病人需要终身吃西药的经济负担。西药厂的风险居然由国家来承担，就是由全民买单的意思，然后成功后的利益再归于西药厂，这种超烂的想法，居然敢说出口，这是因为他认为是理所当然的结果，所以才会脱口而说出真言。)

因此国科会出资八十五%，健亚、中化、南光、永信、台湾东洋及信东等六家本土制药厂出资十五%，总投资金额达一亿七千五百万元，国卫院贡献药物研发专利，共同合作研发出这个属于台湾专利的糖尿病新药。(这个超烂的计划由国家出 85% 的资金，请问将来赚钱时，是否国家可以一直拿 85% 的利润归于国库呢？)

错误的医学研究方向

上篇报导中已经证明了台湾的国科院是一个超烂的国家单位，他们只知如何保护西药厂，完全没有考虑到病人的感受，西方医学从一开始接触到糖尿病这个领域时，就已经走错研究方向或是故意走错方向，所以还是由我来说明关于糖尿病的问题如何解决，比较正确又客观些。

首先我先跟读者们说，西医学说的第一型糖尿病就是所谓的胰岛素依赖型，这种病的产生是因为有的人在注射疫苗时对疫苗产生过敏，才出现胰脏功能丧失的问题，简单的来说，这第一型糖尿病就是西药厂制造出来的问题，没有疫苗的话，根本就没有这种胰岛素依赖型的糖尿病会出现，所以这些病人其实都是西药厂的受害者，应该要跟西药厂去索赔才对，可是西药厂是受到当局卫生署的强烈保护，所以这些病人不但不知道真正的致病原因，也欲告又无门路，终其一生都将受到西药厂的控制，只能替西药厂卖力的去工作赚钱。

第二型糖尿病就是这篇报导的重点了，国卫院的这些专业人士，真正是笨到可以了，我为什么要说这些人很笨呢？因为第一原因是他们真正是很笨啊，我说实话又错了吗？第二原因是从西医学发现糖尿病至今，一直陷在一个观念里，就是如何去控制血糖？当没有新药出现时，就会跟病人说，现在控制血糖的药物很好，没有什么副作用，等到要推出新药时，就会说因为过去的药物副作用很多，所以需要再去研发出新的药物，这样就可以减少副作用的出现，就像上篇中所说的话一样。读者想一想，如果一直只在研发新药来控制血糖，这条路必将越走越窄，就算他们研发出最好的控制血糖的药物，得利的还是西药厂，死亡的还是糖尿病病人而已，但是如果他们已经知道这条路继续走下去的话，跟以前的想法又有何不同呢？用药物去控制血糖的结果，只会造成胰脏更加速的退化而已，根本就无助于病人的健康。

真正正确的想法应该是去研究为什么病人的血糖会上升？是因为病人太喜欢吃宵夜造成血糖上升？还是吃太多快餐或是喝太多可乐汽水造成的呢？还是病人太懒缺少运动而造成血糖上升的呢？还是病人体重过重才造成血糖上升的呢？当医师帮助病人找到真正让血糖上升的原因后，然后建议病人从不正确的饮食生活习惯上去做改变，让血糖下降到正常，这才是一位优良医师应该有的想法，读者说对不对呢？现代的西医师已经被训练成只知道如

何去开降血糖的药物给糖尿病病人吃，根本没有一位西医师会做出像我说的动作来协助病人，这些只知道治标，不知道如何治本的错误医学观念，居然还是被这个国家单位继续在执行中，这就是我说他们既笨又很烂的原因所在，这些笨笨的官员，都应该到监察院跟王院长去自首，跟院长报告说，我就是你口中的那种笨笨的官员，是属于不适任的公务员，请饶恕我的笨笨，让我平安的离开公务员生涯吧，我的位子应该交由比我更有智慧的人来坐，如果此人这样做，我就让他留芳百世，不说的话，为了百姓的健康着想，逼不得以只好让你遗臭万年了。请问台湾的王院长，您说这样做对不对啊？

汉唐中医倪海厦谨记于佛州 2009 年 04 月 18 日

血糖过低要人命

报导/邱玉珍摄影/邱玉珍、阿戴

血糖低不但会对正常人产生怪异行为的副作用，就连必须控制血糖的糖尿病病人，也不见得血糖数值愈低就愈健康。医师警告，糖尿病患者拚了老命用尽各种严峻方法，把数值降至标准值，结果却差一点丧命的例子不少。(过低会要人命，过高也要命，病人该何去何从呢?)

今年五十二岁的陈先生罹患第二型糖尿病已经三年，为控制血糖，除长期服药控制血糖，平常也很努力运动、控制饮食。没想到，在一次骑单车登山的途中，却因为血糖过低导致全身发抖，他从坐垫下方取出糖果就花了一分钟，赶紧想拆开包装纸又折腾了老半天；虽然最后将糖果送进嘴巴，却已来不及，当场昏迷倒地。(这是笨昏的。)

陈先生表示，他的母亲也是糖尿病患者，在洗澡时不幸过世。他说：「我一直以为血糖愈低愈好，不知血糖过低也会丧命；经过这次事件后，回想起已逝母亲，才想到，之前妈妈也是因为低血糖昏倒，等到家人发现时，为时已晚。」(这是笨死的。)

糖尿病是国内罹患人数最多的慢性病，根据国家卫生研究院最新出炉调查发现，糖尿病盛行率已达百分之九。二，每十个台湾人就有一人罹病；其中又以六十五岁以上男性最为严重，几乎每四个六十五岁以上男性，便有一人罹患糖尿病。(为何不说明病因自哪来?)

令人忧心的是，很多糖尿病患者以为血糖愈低愈好，采取严格血糖控制，导致低血糖，引起更严重副作用。台北荣总新陈代谢科主治医师蔡世泽表示，很多糖尿病患者有个错误观念，以为血糖愈低愈好，用尽各种方法，结果杀太大，血糖降过低，反而易引起心血管疾病。(以前怎么不说明如此清楚呢?)

蔡世泽强调，血糖如刀之两面，杀过大也会引发不可弥补的风险。他解释，目前糖尿病的治疗陷入瓶颈，照理说，病人血糖降愈低愈好，但从临床经验来看，并不是每个人都适合把糖化血色素（检验病人血糖控制好坏的指标）降至七以下；上了年纪、有心血管疾病的患者，糖化血色素控制在七以下，反而易增加死亡的风险。(西医学就是昨是今非，病人该怎么办呢?西医说血糖太高会有心脏病与中风，现在又说血糖太低易增加死亡风险，到底要病人该如何做呢?)

抢救不及留遗憾

去年二月，美国糖尿病学会曾发表一篇研究指出，把患有心血管疾病、糖尿病患者的糖化血色素控制在六，经过四、五年追踪，结果发现死亡率远高于只有糖尿病病史的患者。蔡世泽说，大家别小看低血糖，如果患者来不及补充糖分，也会危及生命。因为葡萄糖是心脏惟一的能源，一旦缺乏，对原本受损的心脏造成很大的伤害。

中华民国糖尿病卫教学会理事长许惠恒指出，低血糖症状轻微者，头晕、手抖，若未赶快补充糖分，就可能意识不清，甚至昏迷，发生意外事故。临床上也发现，低血糖也可能让人出现怪异行为；有人出门上班时，突然低血糖，走出家门又转回来，因为忘记自己要去哪、做什么。(既然如此，那到底该不该去降血糖呢?)

三大项危险因子

报导/邱玉珍摄影/邱玉珍、阿戴

许惠恒强调，低血糖很难被察觉，国内一份针对二百多名糖尿病患调查发现，有高达八成的糖尿病友曾出现疑似低血糖症状，其中有四成病患没发现自己有低血糖，出现饥饿、头晕等，严重时甚至会失去意识。他说，发现家人有低血糖症状，可立即给病患吃糖果、糖包等含糖食物，平衡血糖值。(是谁造成血糖过低的呢?)

所谓的低血糖，就是血糖值低于 70mg/dl，症状是会出现饥饿、头晕、无力、发抖、冒冷汗，严重时会导致昏迷，对器官造成伤害。另外，因为低血糖会造成心悸、增加心脏收缩的频率，所以也会提高罹患心血管疾病的机率。(西医以前认为高血糖会造成心脏病，现在又认为低血糖也会造成心脏病，这该如何是好呢?)

蔡世泽强调，低血糖最易发生在年过六十岁罹患第二型糖尿病的病人身上，因为他们大都有十几年病史，吃太多降血糖药物所致。他认为，血糖控制须适可而止，它跟血脂、血压不一样，并不是愈低愈好。目前美国糖尿病医学会对于糖尿病人的血糖控制，采取应依个人健康状况，提出不同的治疗计划。

「为糖尿病患量身订制治疗计划，已成为全球趋势。」蔡世泽说。他表示，国外建议有以下任何一项危险因子的病人，医师都应给予个人化的治疗，才能预防低血糖可能导致的意外。一是年过六十岁以上；二是患有心血管疾病；三是努力积极控制血糖，但血糖依然纹风不动的病人。只要有上述任何一个条件，医师就要为病人量身订制血糖控制计划。(看起来好像是很好的想法，但是真的做得到吗?)

许惠恒也认为，国内罹患糖尿病的病人大多数集中于六十岁以上，他们大都同时罹患心血管、高血压等疾病，如果依照传统治疗模式，患者会把血糖降至过低，而引发低血糖风险。他呼吁糖尿病的病人，必须提高警觉，时常自我监测血糖、规律运动、遵守饮食计划，并按时到医院回诊，才能避免意外发生。(为何不说应该建议病人去找中医治疗呢?)

控制血糖勤记录

在宜兰推动糖尿病共同照护的游俊能医师则表示，帮助糖尿病患控制血糖，不能只靠医师、药物，必须由医师、护理师、卫教师一起共同完成，才能把病人的血糖控制在最理想状态。(有需要这样麻烦吗?)

今年八十三岁的魏老先生，有十八年的糖尿病史，以前根本不知如何控制血糖，能吃则吃，直到血糖飙升才到诊所就诊。经过医护人员解说，魏老先生听从医师建议，每天测验血糖及饮食，记录在本子上，回诊时再给医师参考。(这是好的开始呢?还是噩梦的开始呢?西医只专注于控制，从未想过糖尿病是可以被治好的。)

经过几个月的追踪治疗，魏老先生的血糖控制得很好，「我现在每天都骑着摩托车到海边钓鱼，眼睛跟肾脏也没有发生病变。」操着一口台语的魏老先生很得意地说。游俊能表示，糖尿病患的病情比起其它慢性病来得复杂，病人需要有很大的耐心及毅力，才能把血糖控制在最稳定的状态。(可以控制多久呢?这只是一时的效果，不是永远的效果。)

糖尿病高危险群

有家族史的人：研究指出，糖尿病患的家属罹患糖尿病的机会比一般人高出 5 倍以上。(这是身体上的遗传呢?还是生活习惯上的遗传?)

上了年纪的中、老年人：40 岁以后，100 人中约有 10 人会罹患糖尿病，因此步入中年后应特别留意。(这是因为运动减少的关系吧。)

体型肥胖的人：糖尿病的初发病例中约有 60% 是肥胖的人。(胖子的血糖绝对比较高，所以这些人是需要减肥，而不是降血糖啊。)

糖尿病常见并发症(这句话应该改为--长期使用降血糖药物与胰岛素后常见的并发症--)

报导/邱玉珍摄影/邱玉珍、阿戴

糖尿病是国人罹患率最多的慢性疾病，血糖控制好对身体其它器官影响甚巨。在国内有糖尿病卫教之父美誉的林瑞祥教授表示，血糖控制不好，会造成全身性大小血管的伤害，引起眼睛、肾脏、心血管病变，严重时甚至导致失明、肾衰竭、心脏病等并发症。(这位教授说错话，真正导致这些问题的是降血糖药物与胰岛素，不是高血糖。)

林瑞祥教授强调，很多糖尿病患者都有注射胰岛素会上瘾的迷思。事实上，及早接受胰岛素治疗，不但可减轻肝、肾功能的负荷，还能降低并发症的发生。他建议糖尿病患应好好控制血糖，以免引发严重并发症。(此人说的已经过时了，越使用胰岛素的人，就越容易得到这些病的。)

．大血管病变：脑、心脏及足部等部位的动脉硬化可能造成脑中风、心肌梗塞及足部病变；足部的血液供应减少，造成间歇跛行、足部冰冷、感觉异常、足部易感染、伤口不易愈合，有一半的截肢病人属糖尿病病人。(糖尿病不会引起这些问题，而长年使用降血糖药与胰岛素的病人会出现这种问题的，台湾前总统经国先生就是标准案例。)

．眼睛的病变：糖尿病是造成成人失明的主因，常见的病变有白内障、视网膜病变、青光眼。(控制血糖的药物副作用就是这些，已经有许多长期使用降血糖药与胰岛素的人，得到这些眼睛病变了。)

．神经病变：括自主神经或周边神经的短期或长期受损，引起心悸、腹胀、便秘、腹泻、失禁、小便困难、姿态性低血压、性功能障碍、手脚发麻及刺痛、感觉迟钝。(这些都是长期使用降血糖药物后才会有的后遗症。)

．肾脏病变：起水肿、蛋白尿、血压上升等症状，甚至肾衰竭引起尿毒症，而需要终生洗肾。(我有许多洗肾病患，就是长期使用降血糖药后，造成肾脏衰竭的。绝对不是高血糖造成的问题，因为血糖不都是已经被控制住了吗。)

．癌症：英国曾针对罹癌患者进行大规模研究发现，糖尿病患者发生大肠癌、胰脏癌、摄护腺癌的机率远高于正常人。至于原因为何，目前仍无法确知。(这些癌症是来自西药的副作用，所以当然不能说实话。)

糖化血色素 (HbA1c)

很多糖尿病病患，不知糖化血色素才是长期控制的结果。平常不注意血糖控制，等到要看门诊时才开始服药、饮食控制，希望把血糖控制在理想状态，瞒骗医护人员；事实上，医师只要抽血检测病人的糖化血色素 (HbA1c)，就可以知道病人有没有按时服药、做好饮食控制。(知道的结果就是要吃更多的药，其又如何呢?)

糖化血色素到底是什么，可让病人在医师面前原形毕露？林瑞祥教授表示，血色素是红血球中的一种蛋白质，它主要的功能是将氧气带到组织，并将二氧化碳带离组织。而葡萄糖可以附在血色素上，直到红血球被破坏为止；红血球的平均寿命约 4 个月，被葡萄糖附着的血色素称为糖化血色素。

葡萄糖可自由通过红血球，并经由化学作用附在血色素上，每个红血球中都有少量葡萄糖永久性地附着在血色素上。血糖愈高，永久性附在血色素上的糖分就愈多，所以糖化血色素的百分比可以反映出红血球生存期间内的平均血糖浓度。若以 100% 的血色素来说，一般正常人的血色素黏有葡萄糖的比率是 4 - 6%，但糖尿病人的比率却是 7 - 8%，甚至会高达 16 - 20%。

评论

过去西医一直说高血糖会造成心脏病与中风，现在又说血糖杀很大又更坏，更容易造成心脏的病变，这该怎么办呢？严格控制又不行，不控制也不行，实在左右为难，所以我劝病家，还是吃中药比较好些，然后生活饮食上需要做修改，不吃消夜，不吃西方的快餐汉堡之类，多运动走路，只要正常的吃三餐，不过量饮食，最忌讳暴饮暴食，不要喝咖啡可乐等，当然不要喝牛奶，这样就可以永保消瘦的身材，血糖自然会正常，一但有口渴严重，容易饥

饿，或是性功能丧失等，就该找中医了。

使用控制血糖的方式保持血糖永远是正常，这很难做到，血糖本来就会在饭前饭后出现不同的数值，最好的方式就是要保持脏腑功能的正常，使用降血糖药物与胰岛素的结果，只会让胰脏退化的更快，等到有一天完全退化后，就需加重使用胰岛素，到后来就是眼睛视力出现问题，脚麻没有知觉，一但被感染后，就是截肢，这些都是西药造成的后果，跟糖尿病是无关的。这篇报导除了说明西药一无是处之外，还在推卸责任中。

汉唐中医倪海厦谨记于 2009 年 08 月 20 日

糖尿病药 Rezulin 伤肝药厂隐瞒

编译冯克芸 / 综合华盛顿三十日电

内部文件显示，华纳兰茂公司在促销该公司糖尿病药物 Rezulin（一译瑞素灵）时，公司主管曾向联邦管制人员隐瞒该药伤肝的初步证据，且后来迟迟不将有关此药致命毒性的信息告知全美各地家庭医师。

文件显示，曾有华纳兰茂员工质疑该公司将此药临床报告中伤肝案例总数删减百分之卅八，结果这些员工遭公司管理部门解雇。当时该公司向全美医师保证，Rezulin 跟普通并无疗效的安慰剂一样安全。

美国食品及药物管理局（FDA）在一九九七年初以「速件」方式核准 Rezulin 上市，后有数十件肝脏相关死亡案例与此药有关。二〇〇〇年三月，Rezulin 撤出美国市场，但当时它已为华纳兰茂创下廿一亿美元业绩。

华纳兰茂草菅人命还大赚一笔的丑闻最近才浮上台面。二〇〇〇年中买下华纳兰茂的辉瑞药厂为响应约五千一百名 Rezulin 使用者或遗族提出的两千多件诉讼，已将许多相关文件交给原告律师。法官下令多数文件不得公开，但洛杉矶时报取得一些文件及该公司主管最近在法庭作证纪录。

评论

我一再告诫糖尿病患,血糖高不会伤害眼睛,第一个内脏受到伤害是肾脏,肾主记忆,肾主骨,肾主耳,肾主发,只要先把肾脏顾好,高血糖不可怕,胰岛素注射剂会伤到肝脏,而肝主目,主筋,青光眼就是由于西医使用胰岛素注射剂伤害肝脏而来的,而西医为了逃避责任就怪说如果不使用胰岛素注射剂高血糖会造成青光眼,此一推卸责任的说法,不知害了多少人失明,西医再不说实话,请勿怪我要骂不要脸了。

治疗与预防糖尿病与相关并发症的实证营养原则与建议

【郑维理医师/TrustMed 医学编译中心】

营养治疗是糖尿病管理与自我管理教育不可或缺的一部分，可是，对于营养与糖尿病，仍然存在着许多错误的观念。更有甚者，在临床上，一直而且还在提供糖尿病患者没有或只有很少支持证据的营养建议。因此，这份立场声明就是要提供糖尿病营养治疗的实证原则与建议。这份立场声明的基本原理已在美国糖尿病协会技术性评论「治疗与预防糖尿病与相关并发症的实证营养原则与建议(Evidence-

Based Nutrition Principles and Recommendations for the Treatment and Prevention of Diabetes and Related Complications)」中讨论，它详细地讨论与每一项原则与建议有关的已发表研究（注 1）。

在过去，糖尿病与相关并发症的营养建议是根据科学知识、临床经验与专家共识；然而，通常很难分辨构成建议的证据层级。为了解决这个问题，2002 年的技术性评论（注 1）与这份立场声明根据使用美国糖尿病协会证据评分系统的证据层级，提供原则与建议。不过，目前的最佳证据仍然必须考虑个别的情况和偏好与文化 and 种族的偏好，而且糖尿病患者必须参与决策过程。实证建议的目标，是借着提醒医师与病患们有益的营养治疗而改善糖尿病照护。

因为营养议题的复杂性，建议由一位有执照、对于把营养治疗落实到糖尿病管理与教育上

具有知识与技巧的营养师担任小组中提供营养治疗的成员。不过重要的是，所有小组成员必须了解营养治疗，并且支持需要改变生活型态的糖尿病患者。【备注】

本研究报告中的建议乃根据下列刊物中已审核过的证据：治疗与预防糖尿病与相关并发症的实证营养原则与建议（技术性评论），糖尿病之照顾，第 25 卷，148-198 页，2002 年。

(Evidence-

based nutrition principles and recommendations for the treatment and prevention of diabetes and related complications (Technical Review). Diabetes Care 25:148-198, 2002.)

这篇报导最初的手稿是由下列人士提出：Marion J. Franz, RD, CDE (co-chair),

John P. Bantle, MD (co-chair); Christine A. Beebe, RD, CDE; John D. Brunzell, MD; Jean-

Louis Chiasson, MD; Abhimanyu Garg, MD; Lea Ann Holzmeister, RD, CDE; Byron Hoogwerf, MD; Elizabeth Mayer-

Davis, MS, RD; Arshag D. Mooradian, MD; Jonathan Q. Purnell, MD; and Madelyn Wheeler, RD, CDE.。

这份报告已经过同侪审核、修正，并在 2001 年 10 月经过专业执业委员会及执行委员会核可。【缩写】VLCD (very low caloric diet)，极低热量饮食【审阅】郑慧文，美国加州大学药

学博士【导读说明：本系列共 28 篇】本文是由美国糖尿病协会 (American Diabetes Association) 发表的评论。英文标题为：Evidence-

Based Nutrition Principles and Recommendations for the Treatment and Prevention of Diabetes and Related Complications（治疗与预防糖尿病与相关并发症的实证营养原则与建议）（本系列共 28，此为第 1 篇）

评论

以上这篇文章洋洋洒洒也经由许多专家背书,看起来好像很好,实际上读者什么帮助也没有,此类研究报告到处可见,这类所谓学者只是因为领取了研究经费,赶快写一些东西出来,否则明年研究经费就会被删除,如此之烂的研究报告,不但误导群众,也证明了他们的无知.你只要仔细看看就知道毫无帮助的.

治疗与预防糖尿病的唯一方法就是必须要知道此病由何而来,实际上糖尿病是因为喜欢吃消夜而引发的疾病,台湾人吃消夜是有名的,夜市到处都有,台湾人又喜欢吃,这是中国人的习性,也由于吃消夜之后随即就寝,食物还在胃里时,人体就进入睡眠状态,结果使胃的消化减缓,而食物在胃中停留时间过久,因而使得糖份分泌过多,进入血液中,日积月累下来,就是糖尿病,过去人云"富贵病"就是以前只有有钱人才吃消夜的,现在人们富裕了,吃消夜是很平常的事,故糖尿病患者目前逐年增加中.

病人如果不知道糖尿病由何而来的话,即使治好了,也会再次发生的.至于治疗糖尿病的方法,最好用中药的方式,也就是采用最自然的方法是最好,如多运动,多吃蔬果,保持心理健康,少吃根茎类的植物,至于米饭面类,倒是无妨,远离甜点及消夜.日久自然就会痊愈了.

[医学新知]美研究发现胰腺细胞可自我更新,有助研发一型糖尿病新疗法

[路透华盛顿电]美国科学家周三表示，制造胰岛素的胰腺细胞可以自我复制。这一研究结果显示，少年型糖尿病或称一型糖尿病的患者有望找到新的治疗方法。

专家指出，研究结果还支持了一种观点--使用胚胎干细胞进行争议性的研究，或许是寻找治疗该种病症方法的最佳途径。本项研究报告发表在本周的《自然》(Nature)期刊上。

哈佛大学和霍华休斯(Howard Hughes)医学院的梅尔顿(Douglas Melton)博士和同僚在老鼠体内发现了自我更新的胰腺细胞。

这些细胞被称为 beta 细胞，能够制造胰岛素。但在一型糖尿病患者体内，免疫系统会错误地把这些细胞消灭掉。

梅尔顿和同僚在老鼠胰腺内寻找成年干细胞的证据。他们让老鼠服用抗癌药三苯氧胺 (tamoxifen)，用它作为细胞内的追踪物。这种药物在成熟的 beta 细胞中能够持续存留。

梅尔顿报告说，他们找到的所有新 beta 细胞都含有三苯氧胺，证明它们是由先前存在的 beta 细胞生成的。

费城 FoxChase 癌症中心的扎雷特(KenZaret)博士说，该项研究并未证明胰腺内不存在成年干细胞。「但它确实向我们

指示了一处资源所在：一种能够制造胰岛素的细胞一直都在那里存在着，那就是 beta 细胞本身，」扎雷特在评论中写道。(完)

评论

关于糖尿病,我不知道已经治疗过多少此类病患,西医分为二种糖尿病,一型及二型糖尿病,中医分三种消渴症,都是可以治疗好转的,也的确是西医所谓的一型糖尿病很难治,我遇到过许多如此的一型糖尿病,目前已经找出解决此难治之病的方法,第二型糖尿病几乎是可以治疗到正常人一般的血糖指数,第一型糖尿病会花比较多的时间去治,但是机会较少的.而第一型糖尿病的起因却是西药的疫苗所造成的.

【记者林进修 / 报导】糖尿病患者照顾健康，从足下开始！由于国内糖尿病患者逐年增加，台北荣民总医院新陈代谢科医师蔡世泽建议患者，不妨自行在家检测足部神经反应状况，做为后续治疗依据，避免病情急遽恶化。

据推估，台湾目前有超过一百万名糖尿病患者，蔡世泽表示，糖尿病患者末梢血管血液循环较差，伤口不易愈合，严重者甚至面临截肢、败血性休克而死亡的命运。

然而，足部是身体最远程的部位，常被忽略，医护人员也未重视足部护理的重要性，看诊及从事卫教时，未确实做好足部检查。据统计，罹病 10 年以上的第二型糖尿病患者中，约 1% 会因缺乏正确足部护理而「失足」，其中半数回天乏术，因此，有必要提醒患者切勿「一失足成千古恨」。

台大医学院名誉教授林瑞祥曾根据国外产品，设计出一个符合国内需求的脚底感应探测器，透过尼龙线对脚底感觉敏感区的探触，检测出患者的神经反应情形；一旦检出异常，随即就医接受更详细的检查及治疗，及早控制病情。

财团法人糖尿病关怀基金会卫教师李碧云表示，每个脚底均有十余个感觉敏感区。测试时，糖尿病患者可坐可卧，由家属持脚底感应探测器逐一检查，每个敏感区探触超过 2 秒钟，再由患者的自觉反应中，判断神经反应情形。她强调，探触时只须施放约 10 公克的压力，正常人均可感受得，若敏感区感受不到压力，即属异常。

评论

足部溃烂这种病本来是根本没有的病,完全是西药造成的后遗症(请参考 HT-24),糖尿病患者只要找中医治就可以被治疗的,如果你使用西药想来控制你的血糖,你就犯了第一个错误,经年累月的使用血糖药物就会把多余的血糖沈淀在脚部,于是只要有一个小伤口在足指上,就不会痊愈了,到后来就如同前总统蒋经国先生一样,死前仍要被截肢,结果很惨.但是你如果到了如此阶段,在截肢前夕,找到优秀的中医治疗,仍然有机会可以治疗好转的,不须要气馁.

酏禄类降血糖药可预防糖尿病

【王薇涂棠銓】国内的糖尿病患者越来越年轻化，临床上甚至出现有家族遗传病史的小朋友，10 岁就发病，不过国外的临床实验证明，糖尿病高危险族群服用「酏禄类」的降血糖药物，可以延缓糖尿病的发病时间长达 5 年，还能降低九成的心肌梗塞风险。

国内的糖尿病人口高达 40 万人，其中 50 岁以下的年轻病患就有 25 万人！而且发病年龄越来越年轻化，临床上甚至出现 10 岁的小小糖尿病患。

有家族遗传病史的糖尿病高危险族群，现在可以透过药物预防发病。根据加拿大的跨国临床实验证明，服用酏禄类的降血糖药物可以延缓罹患糖尿病的时间长达 5 年，而且还能预防心血管疾病。

这种降血糖药物可以抑制淀粉吸收，还有减肥效果！如果是预防性的治疗，健保不给付，

每天的药费大约 30 块钱，不过医师呼吁有家族病史的民众，控制饮食、规律运动，是预防糖尿病的根本方法。

评论

诸位看这篇的结尾,是(不过医师呼吁有家族病史的民众，控制饮食、规律运动，是预防糖尿病的根本方法。),民众们有看到吗?答案是没有,因为无知的人居多数,一般人看书的习惯只有专注前段,书尾很少去看,所以一开始就被前段迷惑了,真正要预防糖尿病的方法除了上篇结尾所述的之外,吃消夜是得到糖尿病的主因,诸君看看台湾到处有夜市,多姿多彩的夜生活就是其因,早睡早起运动的人,何来糖尿病呢,不要吃西药与维他命等烂药,也会减少得到糖尿病的机率的.

台湾有 25 万青壮年糖尿病患应定期检测

【记者陈惠珍台北十六日电】根据健保局数据显示，2002 年台湾五十岁以下的糖尿病患者约有二十五万人；新陈代谢科医师也表示，目前台湾另有四十至五十万名青壮年人士为潜在罹患者，医师建议，应注重生活及饮食习惯，更应定期检测血糖，以期及早发现。

已故英业达副董事长温世仁去年突然去世，让社会感到惊讶和惋惜，很多人都知道他是因中风猝死，却不知道二十八岁就罹患糖尿病的温世仁，其心血管疾病是由糖尿病所引起。根据健保局资料，2002 年台湾 50 岁以下的糖尿病患者约有 25 万人。中华民国糖尿病卫教学会理事长、台北荣总新陈代谢科主治医师蔡世泽表示，依照本土研究推估，目前台湾另有 40 至 50 万名社会中坚，其空腹血糖偏高或口服耐糖试验异常，不仅为潜在糖尿病患者，也是心脏血管疾病的高危险群。

他说，以往一般糖尿病患者多在五十岁后才被诊断出来，但是近年来年轻糖尿病患愈来愈常见。糖尿病早期症状并不严重，年轻病患常自恃年富力强，对积极治疗、定期追踪的必要性掉以轻心。

对于正值盛年民众，特别是具备肥胖身材，并并发高血压、血脂异常等「新陈代谢症候群」特征，或拥有糖尿病家族史的人，都需正视及评估未来罹患糖尿病的风险。除了注重平时的生活及饮食习惯，更应定期检测血糖，以期及早发现。

年轻时就罹患糖尿病，也无须恐慌，糖尿病患只要适度的控制饮食与加强运动，积极搭配适当药物治疗，仍可有效遏止或延缓并发症的发生。

蔡世泽并指出，对于可能罹患糖尿病的高危险群，服用具 Acarbose 成份药物，虽仍无法阻止糖尿病的发生，但能将发病的时间延后三至五年，且可降低罹患心血管疾病的风险。

评论

读者看了不要害怕,因为你一害怕就上当了,这就是他们的目的,我治疗许多糖尿病患者,几乎都治疗好转了,因为我们中医治脾先治肾,把肾脏固好,心脏就很安全,西医不知道高血糖必先击败肾脏之后,才会攻击心脏引发心脏病,所以肾脏是把守第一关卡的内脏,目前所有的西药代谢出体外之前都会经过肾脏,就如同吃了维他命之后,小便就变很黄的颜色,所以西药都会伤害肾脏,因此禁绝西药与不吃各种维他命是第一要务,一旦得到糖尿病千万不要慌张,这类的病是难不倒台湾的中医,很简单治的.吃西药越少,好得就越快.

台湾糖尿病死亡率亚洲第一

【中时电子报】

赵家麟 / 台南报导国立成功大学医学中心廿九日表示，台湾糖尿病人的死亡率持续攀升，已跃居亚洲第一位；而国人「血糖控制不良」被认为与死亡率攀升有密切关系。

更令人心惊的是，新的筛检诊断研究结果显示，孩童及青少年罹患第二型糖尿病的人数为第一型糖尿病患者数的六倍。

第二型糖尿病的发生率，在十至十二岁的女孩和十三至十五岁的男孩中，正明显的上升中。

而台湾地区第二型糖尿病的「年轻化」，与孩童、青少年不当饮食、不运动、肥胖等因素，也有极大的关连。

糖尿病自民国七十六年以来，一直居国人十大死因第五位；九十一年、九十二年更挺进到第四位。

去年，糖尿病死亡人数比前年增加一千一百九十五人，每十万人人口死亡率，一年就跃升了十三点〇五%。

成大医院糖尿病人保健推广机构主任张智仁指出，美国糖尿病学会针对糖尿病治疗，有糖化血色素值、血压值、总胆固醇值的三项标准指引；但中华民国糖尿病卫教学会今年的一项研究调查结果却发现，在抽样五千位糖尿病人中，符合这三项标准者，仅仅只有一点三%。

另一个值得国人注意的是，第二型糖尿病已成为台湾孩童及青少年糖尿病的主流；这与传统上将第二型视为「成人型」的认知，已大不相同。

张智仁表示，治疗糖尿病，除了口服药物及注射胰岛素外，非药物的治疗也非常重要，但却很容易被忽略；这包括减轻体重、适度运动、正确的饮食习惯并戒除烟酒、及减少胆固醇的摄取等。

许智仁说，许多研究已经证实，如果能减少现有体重五%至一五%，就可以改善高血压、糖尿病及血脂异常的情形。

但要注意的是，糖尿病人不要空腹运动，尤其是使用胰岛素注射或口服降血糖药物后，应避免低血糖的发作。

评论

台湾的中医可能都睡着了,这些第二型糖尿病是非常好治的,我告诉读者有多快,我一位病患 R 君,体重超过 450 磅,他的血糖是 350,他每天使用 40 单位的胰岛素来控制血糖,结果使用后仍然是 350 不变,吃我的中药之后第二天量血糖就是 120,他还以为他的仪器有毛病,于是向隔壁邻居借来一部仪器再测,仍然是 120,他吓一大跳,居然中药如此之好,我告诉他台湾有非常多的中医都可以治疗你的,不足为奇,他只好傻傻的看我,心中必然十分佩服台湾的中医了,我时常如此对外国人说,总是希望他们能够对台湾另眼相看,因为我诊所的大门口,一年四季都叉着中华民国的国旗,另一边自然是美国国旗,我驻美代表处也不敢如此做,我是小老百姓,政治与我何干呢?

防治慢性病受伤不觉痛糖尿病足要当心【中时电子报】

李哲全（新店慈济医院新陈代谢科医师）糖尿病是一种因胰岛素分泌不足及，或胰岛素作用有缺陷后，导致高血糖的代谢性疾病，会造成全身组织病变，特别是大血管病变如心肌梗塞、中风、周边血管病变；及小血管病变如肾病变导致尿毒症、视网膜病变导致失明、神经病变。（西医分二种糖尿病，一型就是胰岛素依赖型,这是因为注射疫苗造成的副作用,所以是西药厂制造出来的疾病,原本不存在的,第二型是不须要依赖胰岛素的,这是因为生活起居饮食不当引起,找中医就可以治好,如果你选择吃西药控制血糖,你才会面临这后段所说的如心肌梗塞、中风、周边血管病变；及小血管病变如肾病变导致尿毒症、视网膜病变导致失明、神经病变。）

当然，糖尿病足也是一个相当严重的并发症，这些病变会导致患者失能，进而严重影响患者的生活质量及缩短患者的寿命。（这里说的糖尿病足就是使用西药的副作用,不吃西药控制血糖的病人是完全没有这种问题的。）

糖尿病足发生的原因，主要是糖尿病并发的神经病变及周边血管病变所导致。糖尿病患者发生的神经病变，常会侵犯感觉神经、运动神经及自主神经。感觉神经发生伤害后，会使患者手脚末端发麻、刺痛或感觉异常，例如将触觉感觉成痛觉，或像蚂蚁在身上爬的感觉

等等,这种感觉在晚上会特别明显。(这里所说的原因不正确,正确的是因为病人使用降血糖的药,而这失去的血糖并未离开身体,而是沉积在双脚上,日积月累后,才出现以上这些问题的.)

此外,患者对温度、痛觉及震动的感觉也会日渐失灵,最后丧失感觉。这也就是为什么朱先生不小心踢到了一个尖锐的石头却一点也不会痛的原因。而运动神经发生伤害后,会引起肌肉萎缩,致使足部变形,造成足部受压点的压力增加,因此很容易形成「鸡眼」,乃至压疮。(这位朱先生是位西医的崇拜者,所以才有今天的下场,我在这可以预告他的未来,必然是先截肢,然后就是无法控制血糖,于是伤口无法收口,最后因为截肢后的伤口受到病毒感染,使用抗生素无法控制病情,于是死翘翘,这是西医开给前总统经国先生的死亡病历所载.)

自主神经发生伤害后,会使足部的血管调节功能失常,造成部分组织营养供应不良。此外,汗腺也会失去功能,使皮肤容易干裂,发生细菌感染。(这篇报导没有说完,我来说完它,这发生细菌感染之后就死翘翘了.)

评论

读者可以参考我今天写的诊疗日志中的病历,这种西医吸血鬼的行为一定要想办法去禁止,否则冤死的人数只会增加不会减少的,无知的民众赶快醒过来吧,不要再上西医的当了,有糖尿病就快去找中医治,无论温病家或是伤寒家都可以治好你的,但是第一型糖尿病就不是很简单了,因为疫苗已经将你的胰脏完全澈底的破坏了,修补非常困难,要有耐心与毅力才行。

结论是:这种病给西医治,只会越治越坏,从未有一人能够逃出他们的魔掌,请自己决定你的命运吧。

笑疗法每日两回有效降血糖

【编译朱小明/综合报导】

古人说,笑能治百病,日本遗传学家村上证实,开怀一笑真的有帮助糖尿病患者降低血糖的功效,日后医生开处方可能会包括喜剧录像带,剂量是每日两回。(这才是对的医学观念.)

村上指出,「笑疗法」既简单,又省钱,而且没有副作用,他在三年前和日本一家娱乐公司合作,进行笑疗法实验。先让糖尿病患者听一段枯燥的大学课程,再请娱乐公司的头牌谐星来段脱口秀。验血结果发现,比起令人昏昏欲睡的讲课,患者大笑过之后,血糖真的下降了。(这说明了西医每次在吓病人时,病人一听到西医说的话当场就血压高血糖也高了.)

基因虽然难以改变,但有 90% 的基因并不活跃,科学家相信可藉外来刺激把这些基因活化。村上认为,欢笑就是能启动基因疗愈能量的开关。他的研究显示,至少有 23 个基因受到笑声的激发而功能增加,其中 18 个和免疫反应、讯号传导、细胞生命周期有关,另五个基因的功能尚不清楚。(光是靠这 23 个基因就足够了,至少西药是无法做到的,因此笑的开心就可以胜过一切西药了.)

日本西部大阪产业大学在 2004 年进行的一项实验,除了提供老年人医疗,并结合体能训练和笑疗法。92 位参加实验的老人家表示,他们一年的医疗费用降低了三成。(读者看到了吧,我生平最恨西医的吓人方式,他们是既治不好病,同时又将病人活活吓死的医学.)

评论

开心是长寿不二法门,一位永保开心的妇女是不会得到乳癌的,要想真正的开心,只有一句真言,就是心能放得下,要做得得到这种境界,就是要让自己永远保有赤子之心,每天开心的大笑,不仅是对血糖好而已,人体因为气机的流畅而将远离癌症了。前几天大陆网站中古路客医师在临床时遇到一位 103 岁老太太,外表看来只有约 80 岁左右,精神很好,他就问她,妳平常吃什么食物最多,她回答说她最喜欢吃肉,一生如此,我想她长寿的原因就是凡事都放得下,一直都保持开心,所以吃荤一样长寿,许多人认为吃素才健康,实际上是错误的,应该是健康的心才是长寿的泉源阿,

糖尿病易并发心脏病 血糖血压血脂不宜三高

【中央社】

(中央社记者陈清芳台北十九日电)糖尿病呈现年轻化趋势,发生率及死亡率上升,并易并发血管疾病,目前有研究发现,常用的降血脂药物不仅能降低胆固醇,对糖尿病患的护心效果亦很显著。(问题是真正会引发心脏病的并非高血糖,也非高胆固醇,而是湿痰,这些湿黏黏的痰,包着心包膜,一旦屯积不去,将造成心脏的负担,这才是引发心脏病的真正祸首,而今许多人每天都在吃降血糖与降胆固醇降血脂的药物,结果是照样得到心脏病,所以病因的正确与否非常重要,西药厂说不正确的病因,其真正目的只是想卖药而已,因此这些西药不但是无法预防心脏病,反而会引起其它的病变。)

中华民国糖尿病卫教学会理事长蔡世泽医师表示,糖尿病罹病十年后,病人发生过冠状动脉心脏症和中风者,高达百分之五,有的甚至逼近百分之十。(这是因为这些病人都用西药在控制血糖,才会导致如此,也就是说西药才造成的心脏病与中风。)

根据国内外的研究,心血管疾病是造成糖尿病人死亡的主要原因,约占三分之二;糖尿病人如果同时有血脂异常现象,则其发生心血管病的机率为正常人的七点五倍、死亡机率为一般健康正常人的二至四倍。(糖尿病人会出现血脂异常现象,归咎其因就是服降血糖药物造成的,不吃西药根本就不会有这问题发生。)

他说,美国心脏学会有报告显示,常用的司他汀(STATINS)类降血脂药可以减少低度胆固醇的合成,对糖尿病合并高血脂的病患而言,能有效降低心血管疾病、脑中风的发生率;另外也有报告说,某一种司他汀类,对心血管疾病手术后的病患,亦有保护作用。(这里就是全篇报导的重心所在,就是要卖药,此药如果有用,我不会骂的,我很肯定告诉读者们,此药不但毫无疗效,其副作用很多,甚至于引发癌症,所有会让胆固醇下降的药物,都是会致癌的。)

由于血糖、血压、血脂的「三高」疾病来得无声无息,糖尿病卫教协会也建议步入中年的民众透过测量、预防控制、诊断与药物治疗等三管齐下,将可及早发现、及早治疗。(这个协会必定是西药厂或是西医成立的,因为全篇不见他们提到中医,他们不想让百姓了解这糖尿病中药是可以治疗的,完全不须要吃一辈子的西药,因为百姓一旦了解后,必然丢弃西药,他们就没钱可赚,那怎么得了。)

评论

这种浮烂的论文到处都有,每天都是满天飞舞,迷惑人心不遗余力,上篇中提到的糖尿病,高血脂,高胆固醇等三种问题,其实都是可以药而愈的,读者只要改变一下生活习惯,调整一下饮食材料,一段时间以后,自然就好了,不须要小题大做的去吃药控制,一旦吃上西药要摆脱就很难了,结果病人死时是因为药物而死,不是因为疾病而死的。

研究:喂母乳可降低罹患第二型糖尿病机率

【法新社郑诗韵】

(法新社华盛顿二十三日电)美国医学会期刊今天刊登的研究报告显示,喂母乳至少六个月的母亲,可能降低罹患第二型糖尿病的风险。研究显示,每多喂一年母乳,罹患糖尿病的风险就越低。过去已有研究发现,喂母乳的母亲血糖值较稳定,但这是第一份显示母亲喂乳时间长短与降低糖尿病风险有关的研究。哈佛医学院与布里翰妇女医院的研究人员,针对两组母亲进行研究,一组有八万三千五百八十五名,另一组有七万三千四百一十八名。研究发现,在过去十五年间生育的女性,如果哺乳,罹患第二型糖尿病的比率降低一成四到一成五,但研究并未显示十五年前生育者罹患糖尿病的风险是否也会降低。

目前约有九万名美国女性罹患第二型糖尿病。

评论

这种研究在正统中医眼中,根本就是错误百出,毫无根据的研究,西医所谓第一型糖尿病是因为施打疫苗造成的后遗症,而第二型糖尿病是因为好吃消夜,或是暴饮暴食引起的,跟是否有

喂母乳是无关的.我有许多男病人,他们都得到第二型糖尿病,而终其一生,他们从未做过喂母乳的工作,这就是明证了.

台湾每小时 1.2 人死于糖尿病

(中央社记者陈钧凯台北五日电)台湾糖尿病的死亡率正在攀升中,根据统计,去年糖尿病的总死亡人数逾上万人,换句话说,平均每小时就有一点二人因糖尿病失去生命,与自杀同为增加率攀升速度最快的十大死因。医师提醒,现代人高热量的饮食习惯及少运动是主因。(这里只说对了一半,西医所谓的第二型糖尿病的确是这么得到的,而第一型糖尿病却是西药厂制造出来的,因为是病人对疫苗产生不适应而造成的终身伤害。)

中华民国糖尿病卫教学会上午举办「十周年年会暨学术研讨会」。糖尿病卫教学会理事长许惠睎说去年糖尿病的死亡率增加了百分之十三点八,增加的速度甚至超过十大死因前三名的恶性肿瘤、脑血管疾病及心脏疾病。(这个数据已经证明目前的医学是错误的,如果是对的,为什么数据会如此,而目前的医学就是西医学,所以西医学是错误的医学。)

据卫生署统计,二〇〇五年台湾糖尿病的总死亡人数为一万零五百零一人,平均每天有二十八点七人、每小时有一点二人死于糖尿病。糖尿病就医人数达到八十万人,就医费用超过新台币三百多亿元,占健保支出的一成以上。(这个最烂的西医开的公家公司,居然自己已经承认西医学是害人的而不自知,似乎还很得意的样子,其愚昧如此,难怪会相信西医学。)

许惠睎说这还只是低估的数字,若加上其它因糖尿病并发症而死亡的病患,人数可能更多,尤其糖尿病在诊断后十年,视网膜病变、神经病变及肾病变的盛行率高达三成,以洗肾为例,全台目前正接受洗肾的四万名病患内,就有一万五千至两万人是糖尿病病患。(读者看到了吧,我一直在说西药厂在害人,这里的数字已经证明我是对的,但是你们的卫生署可知道吗?答案是当然不知道,一旦他们承认他们错了,如何对人民来做交代。这段落中出现的所有疾病都是因为使用西药去控制血糖后,所造成的后遗症,原本糖尿病是不会有这些问题的。)

虽然台湾糖尿病仍以四十岁以上民众盛行率最高,约为百分之十一至十三,但许惠睎说青少年罹患糖尿病的例子也不少,他本身就治疗过一名十岁、才国小五年级的小男生,小小年纪就因为肥胖、加上有家族病史罹患第二型糖尿病,必须终身服药控制。(这类小孩会得到糖尿病的主要原因是喜欢吃快餐,再加上喜欢打电动玩具,不愿意运动所造成的,与家族史是无关的。)

这名小男生身高一百六十五公分,却有七十五公斤重,平常嗜食炸鸡、薯条、汉堡等高热量食物,又爱喝甜的饮料取代开水,加上超时看电视及打计算机,因为夜间小便次数增多、体重异常降低才就医,一验血糖才发现,每一百 CC 血液中血糖值高达两百八十毫克,远超出一般人平均值的一百毫克。(我的话尚在余音绕梁,正确答案就已经出现了。)

许惠睎说糖尿病病患中约有四分之三,控制成绩都不佳,主因就是个人的生活饮食习惯无法配合,他呼吁,想要有效控制糖尿病不恶化,不可或缺的三法宝就是饮食控制、规则运动及按时服药。(这段结尾就不正确了,正确答案应该是要找中医来治疗,目前世上也只有中医学有办法治疗糖尿病。)

评论

上述报导已经很明白的告诉读者,当你得到糖尿病后,你去找西医的后果就是眼睛出问题,神经出问题,加上洗肾,台大医院的医师最喜欢跟病人说吃中药会造成肾衰竭,现在这位西医却承认是因为控制血糖的西药造成洗肾的,所以读者千万不要相信台大医师的话,这篇报导就是证据了,读者绝对不要去相信一位活的比街头游民还短命的医师所说的话。

新一代药水减少糖尿病透析副作用

更新日期:2006/12/06 19:15

(中央社记者陈清芳台北六日电)患糖尿病又末期肾衰竭的人,易因腹膜情况不佳,在接受腹膜透析(俗称洗肚子)时,容易吸收其中的葡萄糖,致愈洗人愈胖,最近医界引进不含葡萄糖成份的透析液,可减少这方面副作用,可是由于健保给付条件严格,部分医院只好游走健保法规边缘,让病患持健保卡使用但需贴补差额。

新光医院肾脏科主治医师江守山指出,末期肾病患者中,有四成是糖尿病造成,仅次于肾丝球肾炎,大多数末期肾病患者是接受洗肾,只有百分之七的人接受腹膜透析,大约有四成的腹膜透析患者会因为糖尿病使得腹膜通透性变差,以致过度吸收传统腹膜透析液中的葡萄糖,额外的热量使得病患容易发胖。

在江守山的肾病患者中,有位四十二岁女子就因为糖尿病合并末期肾病,腹膜透析一年半,胖了十五公斤,后来有一部分改用玉米糖成份的透析液,新旧透析液交替使用,因为玉米糖不容易被人体吸收,四个月体重降了二公斤,连血糖的控制都变好。

但是,这位女子的腹膜情况不是最糟,因此不符健保给付条件,所以是以健保卡使用较贵的新一代透析液,每天使用两袋,每袋透析液再贴补健保给付不足的新台币一百元。

今天一场腹膜透析病友会中,多位病友也分享自身的经验,其中,李正诚二十二年前得知自己将血液透析(俗称洗肾,洗腰子)时,一度想要跳楼自杀,洗肾九年后他换肾,但换肾至第九年时失败,四年前改用腹膜透析,他说,他不希望每周三次上医院洗肾,腹膜透析让他可自己在家进行,现在「透析液是他的救命圣水」,在和肾病搏斗的二十多年期间,他全力工作,还获选为国营事业模范劳工。

研究:蜂蜜可挽救糖尿病患者免于被截肢

更新日期:2007/05/05 10:05 记者:卢瑞珠

(法新社威斯康星州麦迪逊四日电)美国威斯康辛大学医学暨公共卫生学院的一份研究报告指出,糖尿病患者受感染溃烂的足部伤口涂上一层蜂蜜,可免于截肢的必要。(这里直接说出西医对于这种病情无法有效治疗,所以才会另寻他法,正统中医不用蜂蜜,我们是用蔗糖细粉来做外敷,我就用蔗糖治疗过许多这类病患,效果十分惊人,连本地的西医都不反对。)

一名医学院医师在一组对照性实验中,以蜂蜜帮助六位糖尿病患者免于截肢,推广蜂蜜治疗的广泛疗效。她所使用的方法是,先去除伤口上的死皮组织和细菌,再挤一层厚厚的蜂蜜涂在伤口上。

威斯康辛大学医学暨公共卫生学教授艾迪表示,蜂蜜含有酸性物质,可以杀死细菌,同时可避免使用标准抗生素所产生细菌抗体的并发症。(这里说出蜂蜜是酸性的,而中医用的蔗糖是碱性的,所以我可以肯定用蔗糖的效果一定比用蜂蜜来得好。)

她说,这对全世界卫生医疗来说,是一项了不起的重要议题。

糖尿病患者通常血液循环不良,抵抗感染的能力也变差,一旦有溃烂现象就很难治愈。艾迪表示,全世界每三十秒就有一名患者被截肢。(这是西药厂制造出来的问题,中医来治疗糖尿病不会需要截肢的。)

她认为,假如能证实蜂蜜可以促进糖尿病溃烂的伤口愈合,许多患者将获得新希望,更不用说成本效益和细菌抗体问题。

蜂蜜疗法已经在纽西兰被用来治疗褥疮,在欧洲也成为一种替代药物。(西洋人毕竟没有想到,中医早就知道用甜味来收敛伤口,但是却不知道蔗糖好过于蜂蜜。)

她希望有关蜂蜜的疗效实验完成后,能在二零零八年或二零零九年前发表结论。

评论

我因为在传承人纪中,实在无法找出时间来写医学报告,等到我教完金匱后,我会开始一系列的写些医学论文给医师来研究,以后我会逐渐退出第一线,治病将由我的学生来做,我将开始撰写地纪,像上述的治疗法我早就用过甜味来帮助病人收口,至于糖尿病病人足

底溃烂的真正原因，是因为病人长期使用降血糖药物与胰岛素来控制血糖而造成的，并不是因为糖尿病造成的问题。

胖小子多渴多尿糖尿病上身

更新日期:2007/11/25 07:20 记者张念慈 / 新竹报导

新竹市 15 岁王姓国中生从小爱吃快餐，不爱运动的他体重飙到 100 公斤，出现口渴、多尿症状，医师诊断他患有中年人常见的糖尿病，让原以为「能吃就是福」的家长吓傻，赶忙为他拟定减重计划，并接受胰岛素和口服药物以控制血糖。(这是因为无知的父母造成的问题，我国五千年来的最伟大研究，就是中国食物，怎么笨到让小孩去吃西洋食物呢?)

署立新竹医院内科主任杨宏智表示，王姓少年因容易口渴、多尿来院就医，身形肥胖的他表示三餐爱吃炸鸡、薯条，最爱喝可乐，他的父母陪同就医时还说「儿子胖胖的才可爱，小时胖不是胖。」不解年纪轻轻儿子怎会如此虚弱。(做父母的居然如此愚昧，真是教育出现问题了，不知现在是谁在干教育部长，真该打屁股。)

院方检查发现，王姓少年血糖值将近 800，正常值是 60 至 115，是典型的糖尿病，院方先给予点滴注射及胰岛素治疗后，再改以口服降血糖药物治疗，目前持续使用口服药物来控制血糖。

杨宏智指出，青少年糖尿病典型多半是第一型糖尿病，或称为「胰岛素依赖型糖尿病」，特征是分泌胰岛素的细胞受到免疫反应破坏，造成胰岛素分泌严重不足，需打胰岛素才能维持生命。(这里说的第一型糖尿病，就是打疫苗造成的副作用，原本不该有这种疾病存在的，这是西药厂所制造出来的疾病。)

这名 15 岁青少年却是罹患「第二型糖尿病」，多发病于中年以后，和肥胖有相当大关系。

杨宏智说，青少年的第二型糖尿病过去相当少见，近年来因饮食和生活习惯改变，青少年肥胖人口迅速增加，统计约 15% 青少年有肥胖症状，导致糖尿病产生。

要治疗青少年第二型糖尿病，重点是饮食生活习惯改善和口服降血糖药物，「体重控制」也很重要，需减少高热量食物摄取及增加运动。因糖尿病症状难从外表看出来，体重超重的青少年可做例行性血糖检验，及早发现糖尿病，予以治疗。

糖尿病控血糖死亡率升高

更新日期:2008/02/08 08:40 编译王丽娟报导

数十年来，研究人员始终认为，糖尿病患降低血糖，同时可降低死于心脏病的机率。但美国官方卫生机构一项大规模研究发现，严格控制血糖反而提高死亡率。由于结果出人意外，这项以上万名中老年第二型糖尿病患者为对象的研究，已紧急喊停。(读者可知道这研究明明是对民众很有利，但是现在为什么要喊停呢?只因为对西药厂不利，对美国不利，对 FDA 也不利，因为他们是既得利益者，一旦被否定，将失去大量的财富，人民的生命怎么能跟钱财来比，对他们而言，钱财才是最重要的大家可知道吗?真是太烂了。)

尽管如此，研究人员建议，任何病患想换药使用，均需征求医生的意见。目前，研究人员仍不清楚严格控制血糖反而提高死亡率的原因。(真是笨啊，答案就在自己说的话中，他们自己都在说严格控制血糖是主要原因这句话，请问读者是谁在严格控制血糖呢?除了使用西药才可以来严格控制血糖，还有谁能呢?)

纽约时报报导，这项六日公布的研究发现，将血糖降到正常浓度的一组，死亡人数较血糖控制较不严格的一组多出五十四人。这些接受实验的病患平均参与四年。

上述结果并不代表控制血糖毫无意义。降血糖可减少糖尿病患发生肾脏病、眼盲和截肢等并发症，但新发现显示，传统认为把血糖降得越低越好，或血糖应尽量降到正常值的信条，不见得是定律。(这里在胡说八道，真正会发生肾脏病，眼盲，截肢等问题，是因为西药引起的，中医五千年来的文献中，对于消渴病没有这种记载的。)

医学专家对上述结果颇感惊讶。「美国心脏病学院」院长杜夫说：「新发现令人不安与困扰。」

五十年来，我们一直强调降血糖。」华盛顿大学的糖尿病研究人员赫许表示很难向病患解释上述研究结果，许多病患严格执行饮食控制与用药多年，很难说服他们放宽对自己的要求。(自己骗人骗了五十年，谎话说了五十年，已经积非成是，这要怪这些在西药厂中的骗子，现在这些骗子想要说实话却推托说是很难的事，难道还要继续再欺骗下去吗?)

预期「美国糖尿病协会」也会陷入两难之境，该组织的指导原则至今仍是患者血糖越接近正常越好。(知错能改，善莫大焉，这些协会现在已经知道过去错了，如果不改，那许多不该死的继续在死翘翘中，这些笨蛋该怎么办呢?)

糖尿病分为先天性的第一型糖尿病和成年后罹患的第二型糖尿病，后者占有所有糖尿病的九成五。由于降低血糖理论根深柢固，因此一九九〇年美国国家卫生研究院「国家心肺及血液研究中心」与「国家糖尿病、消化、肾脏疾病研究中心」建议作这项糖尿病研究时，完全没料到会出现这样的结果。(我早就说过西医的医学理论是错的，所以完全没有出我的意料之外。)

参加研究的对象平均六十二岁，糖尿病史十年，除了高血糖，这些病患可能还有心脏病、高血压、高胆固醇等毛病。(西医对于心脏病与高血压跟高胆固醇的研究也是错的，他们其实也已经知道，只是不知该怎么说出口，真是不诚实。)

研究共分成血糖、胆固醇、高血压三组。血糖的实验已停止，其它两组仍继续进行。血糖组分成两个对照组，严格执行血糖控制的一组，一天可能施打四到五次胰岛素，或一天检查血糖七到八次，有时还配合药物使用，将血糖降到尽可能正常，没想到死亡率还高于血糖控制较不严格的对照组。(这里的另外胆固醇与高血压二组的研究，也会跟降血糖的一组一样，得到相反的结果，我保证他们会把自己吓死。)

研究人员原本怀疑某种药物或药物间的交互作用造成这种现象，但经仔细研究分析，已排除这种可能。两组患者的死亡病例也大多是因为心脏病，而非其它不寻常的死因。这项颠覆性的发现究竟原因为何，有待进一步研究。(造成糖尿病病人因为心脏病而死的主是因为使用控制血糖药物所造成的副作用，并不是因为血糖高而造成心脏病死亡的。)

评论

中医五千年来对于消渴病的治疗，不但非常明了病因跟病症，同时也有许多非常好的中药来根治它，使用中药来治疗所谓的糖尿病，绝对毫无任何副作用产生，西药厂开发的降血糖药物的毒素，长期的累积在人体内，才是真正造成肾脏衰竭与心脏病与截肢等问题，这跟高血糖是无关的，所以我一直在说，使用西药来降血糖，只会加速病人提早死亡而已，病人未蒙其利而先受其害。

西药厂制作的降血压药物，将比降血糖药物更坏，让人更痛苦又更短命，不但无助于预防病人得到中风，反而让病人更容易得到中风，这种适得其反的结果，出现在许多西药厂的研究上，高血压只是其中一个超烂的研究罢了。

胆固醇是非常重要的，但是西药厂却误将友人做敌人，利用大量的研究想来证实他们是对的，但是根据我多年的临床经验告诉我，他们又错了，他们认为坏胆固醇会导致心脏病发作，事实上却不是这样，他们所谓的坏胆固醇，其实是人体抗癌的必要物质，如果太低，人们就更容易会得到癌症，所以你如果相信西药厂的研究，一直不断的吃降胆固醇的西药，那你就是在替自己制造癌症中，所有市面上强调低胆固醇或是没有胆固醇的食品，大家绝对不要去买，因为会致癌的，这些都跟西药厂所说的相反，大家不要再相信西药厂了，这些只会做官商勾结勾当的恶人，必须铲除，人们才会有安和乐利的生活出现。

英文报导---<http://content.nejm.org/cgi/content/full/358/24/2545>

<http://www.medicalnewstoday.com/articles/110410.php>

测血糖饭前饭后都要

更新日期:2008/11/13 07:40 记者修瑞莹 / 台南报导

国内糖尿病盛行率逐年攀升，医师表示，目前健康检查多数测量饭前空腹血糖值，忽略饭后血糖值，可能造成部分患者无法提前被筛检出来，建议最好饭前、饭后的血糖值都要测量。(大错特错，如果读者真的这样做，你的一生就完蛋了，只是为个数字而活着，人生就是灰暗的。)

成大医院家庭医学部预防保健科主任吴晋祥表示，目前健检重点是测量饭前血糖值，40岁以上民众每3年1次免费健检或劳工健检等，为方便都测量饭前空腹血糖，但其实有必要测饭后血糖。(真是小题大作，毫无益处。)

他指出，国外曾进行大规模的研究，饭前血糖被测出异常证实罹患糖尿病的比率，与饭后血糖被测出异常证实罹患糖尿病的比率，后者是前者的两倍，可以看出饭后血糖测量的重要。(此人又说错了，根据最近国外的大规模研究，越严格控制血糖值的结果，就是死得越快，根本就不是他所说的。)

饭前血糖值 100mg/dl 以下为正常、126 以上为糖尿病，饭后血糖值 140 以下正常、200 以上为糖尿病，介于 101 至 125 及 141 至 199 则称为糖尿病前期。

吴晋祥指出，成医家医部曾针对台南市小区 412 名糖尿病前期患者进行调查，其中 139 人饭后血糖偏高、但饭前血糖仍正常，约占 1/3，显示如果只做饭前血糖的测量，很可能漏失即早发现血糖异常。(真是完蛋了，台湾人如果听他说的话，就真的自陷于痛苦的绝境了。)

他并称，根据国外的研究，糖尿病患者在发现罹病前，前期症状平均约 6 年，靠着饮食控制、运动与减重，能大幅降低进展为糖尿病的机率，但如果太晚才发现，想恢复健康的机率很低。(无论何时才发现都没有关系，尽快找优秀中医来治疗才是正确的做法，千万不要找西医。)

他指出，测量饭前血糖值，受检者空腹抽血测量即可，但测量饭后血糖，须在空腹饮用葡萄糖水后 2 小时测量，如果用餐后测量，可能随着吃的食物不同而影响准确度，对受检者很麻烦。(根本无须如此大费周章的做血糖测试，没有用的，应该找出方法将糖尿病病治好才对。)

他提醒民众不要以为自己的饭前血糖正常就没有问题，如果觉得自己罹病的风险高，应在例行健检外，加测饭后血糖，提高及早发现血糖异常的机率。(给西医发现，只会制造出更多的麻烦，越治就越坏。)

错误的医学观念

病人担心血糖过高会引起心脏病与脑中风，这是西医给大家错误的观念，目的是要引起大家恐慌，如此它西药厂才能得逞，大卖其害人早死的控制血糖的西药，大赚其黑心钱，读者不要担心，我们人体非常的精密，任何心脏病或是中风，其发病之前必有预兆，主要预兆就是没有原因的失眠，读者如果出现无厘头的失眠，此时就要注意了，你将有高风险会得到心脏病或是中风，此时请就近找中医来治疗，也只有中医知道如何预防你会得到心脏病与中风，千万不要以为将血糖控制好，就可以避免得到这些病，你就大错特错了。

控制血糖糖尿病患防失明

更新日期:2009/04/13 04:09

(记者杨菁菁 / 高雄报导) 糖尿病血糖控制不佳，眼睛失明机率增高！医师呼吁患者控制血糖，有助于减少或遏止视网膜病变。(这里说错了，是控制血糖的药物造成视力问题，而不是高血糖伤害到眼睛。)

影帝陈松勇因糖尿病并发症，导致双眼视力严重退化，引发很多糖尿病患恐慌，最近几家眼科诊所明显感受到糖尿病患关心视网膜有无病变。(这位陈先生必然是长期吃西药才造成双眼视力退化，而不是因为糖尿病并发症。)

信合美眼院长杨志盛表示，糖尿病所以会引发失明之虞，主要是视网膜病变造成，随着罹患的时间愈长并发的机率就愈大，10 年期的机率约 40%，15 年以上 80%，20 年以上则

高达 90%。(这里提出的视网膜病变，就是长期服用西药才造成的，而跟糖尿病无关。)
视网膜病变是因糖尿病引起视网膜血管阻塞，造成视网膜组织缺氧，血管会渗出血液，造成视网膜水肿及眼内出血，若未及时治疗便有失明之虞。(这需要找真正的中医来治疗，西医药只能做暂时缓解症状，无法治好的。)

糖尿病 10 年以上的患者要特别注意，平日按时服药，配合饮食。(这里说的十年，也直接表示这些病人已经吃西药十年以上，这就是说明了，使用西药控制血糖，十年以后就会出现眼睛问题，这不是刚好证明是控制血糖的西药，在病人使用十年以后，就会出现眼睛问题，而不是血糖造成眼睛退化的吗?)

错误的医学理论

最近正好我有一位病人，他因为验血时被验出血糖过高，指数是 253，所以美国西医一直威胁他，不吃降血糖药物控制血糖的话，将无法活过一年，而这位地道的美国白人却不相信他的医师，直接来找我治疗，他告诉我当他体内的血糖上升时，他自己就会知道，因为此时他的视力突然就变得非常好，完全不须要带老花眼镜，他也深深知道西药的害处，所以他来找中医治疗，之前他就已经吃中药减肥体重少掉一百磅，现在还是过重的体格，只要我将他再瘦下来些，自然就会回到正常了。

这篇报导是非常矛盾的，西医说不控制血糖的话，以后就会出现视力退化的问题，现在已经有无数的糖尿病患，长年都在使用降血糖的药物或是施打胰岛素，按照西医的说法，在这种血糖被严格控制的情形之下，就应该没有视力退化的问题存在，对不对?但是结果却是正好相反，已经有许多的病患长年配合医师的指示吃药，十年以后，还是出现视力退化的问题，经国先生就是一例，请有糖尿病的病患，去找中医来治疗，这样才有机会眼力不会退化的。

汉唐中医倪海厦谨记于 2009 年 04 月 13 日

低血糖威胁 4 成病患不自觉

更新日期:2009/07/27 19:09 林怡秀、马绍伦

【台湾醒报记者林怡秀、马绍伦报导】威胁糖尿病患的不只是高血糖，低血糖的危险性同样不能轻忽！根据调查显示，有近八成的糖尿病友曾出现疑似低血糖症状，其中又有 4 成病患没发现自己有低血糖，出现饥饿、头晕等，严重时甚至会失去意识。医师说，这时可给病患吃糖果、糖包等含糖食物，平衡血糖值。(民众相信西医学的结果就是怎么做都不对，低血糖用中药治疗是恢复最快的一种症状。)

许惠恒进一步指出，所谓的低血糖，就是血糖值低于 70mg/dl，症状是会出现饥饿、头晕、无力、发抖、冒冷汗，严重时会导致昏迷，对器官造成伤害。另外，因为低血糖会造成心悸、增加心脏收缩的频率，「所以也会提高罹患心血管疾病的机率。」(不是血糖过高，就是血糖过低，真是无所适从。)

中华民国糖尿病卫教学会理事长许惠恒表示，糖尿病患者为控制病情，会接受胰岛素或胰岛促进剂及多种降血糖药物来降低血糖，一旦病患未按照正常时间进食，很容易就会出现血糖过低的现象，「因为药物会让血糖降低，如果没有补充食物、让血糖达到平衡，就会有低血糖的危险。」许惠恒说。

当低血糖急症出现时，意识清醒及意识不清各有不同的急救方式，「如果病患还算清醒，这时可以给病患吃糖果、糖包或糖水等含糖食物，半小时后再测量血糖是否恢复正常。」如果病患已经失去意识，可从齿缝灌入蜂蜜、糖浆或施打升糖素，千万不要灌食其它液体，以免病患呛到，并立即送医。

至于怎么做才能预防低血糖的发生？许惠恒说，保持正常饮食及作息很重要，「只要三餐少吃一餐，就有可能发生低血糖。」另外家人可协助病患随时追踪、记录血糖，还有规律运动、按时回诊，将血糖值控制在平衡状态，就能远离低血糖威胁，控糖之路走得更平稳。(可是

最新的研究报告却证明出越控制血糖，寿命就越短。)

错误的医学理论

人体任何器官的功能是不可以使用控制的方式来制衡的，必须找出方法让失去功能的内脏重新恢复功能才对，否则吃这个也痒，吃那个也痒，怎么做都不对，如果一个人每天都在想如何将自己的血糖控制得很好，那人生有意义吗？当这些笨蛋在思考如何控制血糖时，我却在思考去何处静思一下，如何再让自己的智慧更上层楼？如何去欣赏大自然的美？何谓捻花微笑？我跟这些笨蛋的想法是完全南辕北辙，风马牛不相干，他们这些人真是很奇怪，为何总是想出些东西来虐待自己？想尽办法让自己不开心，让自己更短命些。

读者请注意，高血糖是可以治疗的，而低血糖比高血糖来得更容易治疗，时常可以是一剂就知，二剂就好的疾病，但是必须使用经方才行，有问题请找我的学生来治疗，如果使用温病派的增润津液方法是无法治好的，读者如果受到上面这位西医师的影响，只知道一昧的控制血糖，你的人生将变成灰色的，毫无生活质量可言，一般我都是要我的敌人去听西医的话，这是消灭我的敌人最合法的方式了。请恨我的人，尽情享受控制血糖的日子吧。真是笨啊。

汉唐中医倪海厦谨记于佛州 2009 年 07 月 27 日